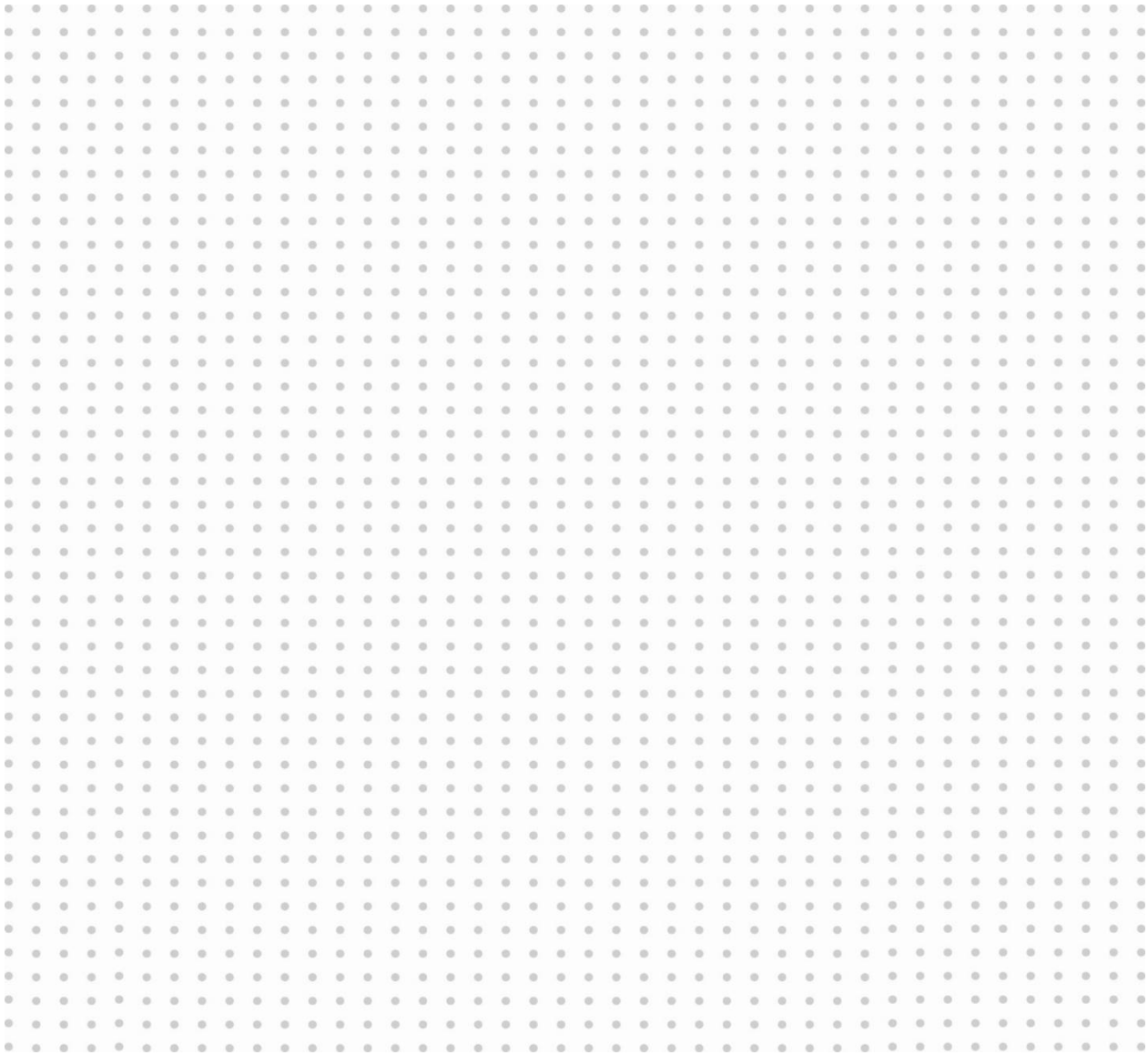




**PLAN DE EMERGENCIA CESFAM DR.
ORLANDO LEYTON A. PERALILLO
ENERO 2026**

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 1 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

PLAN DE EMERGENCIA

[CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A. PERALILLO]

Elaborado por: NOMBRE: DR. ELIGIO MACHADO R CARGO: INTEGRANTE EQUIPO COGRYD CESFAM PERALILLO.  Dr. Eligio Machado R. Médico Cirujano Rut: 25.721.626-8 FIRMA Y TIMBRE Fecha: 05-01-2026	Revisado Por: NOMBRE: MARIA JOSÉ SOLIS CARGO: INTEGRANTE EQUIPO COGRYD CESFAM PERALILLO  Maria José Solis Letelier Rut: 16.432.757-4 Enfermera FIRMA Y TIMBRE Fecha: 06-01-2026	Aprobado por: NOMBRE: CRISTIAN CARDENAS E CARGO: DIRECTOR CESFAM PERALILLO  CESFAM PERALILLO DIRECTOR DEPTO. DE SALUD FIRMA Y TIMBRE Fecha: 07-01-2026
--	--	---

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 2 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

CONTENIDO

1.	Presentación.....	4
1.1.	Antecedentes	6
a.	Objetivos	9
i.	Objetivo General	9
ii.	Objetivos Específicos.....	9
b.	Cobertura, Amplitud y Alcance	10
c.	Relación con Otros Planes.....	11
7.	Levantamiento de Recursos y Capacidades Institucionales y de la Comunidad	11
8.	Coordinación	18
a.	Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).....	18
i.	Activación, Convocatoria y Auto Convocatoria	19
ii.	Definición de Roles y Funciones.....	20
b.	Coordinación Institucional	22
i.	Fase Alerta.....	22
ii.	Fase Respuesta	23
iii.	Fase Rehabilitación.....	26
c.	Coordinación Interinstitucional.....	27
i.	Fase Alerta, respuesta y rehabilitación	27
9.	Comunicación e Información	27
a.	Sistema de Telecomunicaciones	27
b.	Información a la Comunidad y Medios de Comunicación.....	28
10.	Activación del plan	29
11.	Evaluación de Daños y Necesidades.....	31
12.	Implementación, revisión periódica y Readecuación del Plan.....	31
13.	Anexos	33
a.	Cuadro de Control de Actualizaciones	33
b.	Marco Legal y Normativo	33
c.	Matriz de Riesgo o de Amenazas del establecimiento.....	39
d.	Ficha de Reporte General de Emergencias (Debe realizarlo el Coordinador GRD- Referente técnico SUR).	47
e.	Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN (Lo debe realizar Referente Administrativo SUR)	48
i.	EDAN Establecimientos	48
ii.	EDAN Salud Mental (Lo realiza Encargada Salud Mental).....	51
f.	Ficha de Enlaces – Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRID del establecimiento (titulares - suplentes) y otros enlaces relevantes	56

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 3 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

g. Ficha de Enlaces – Extra Sectorial (titulares - suplentes) 58

h. Farmacia – Medicamentos críticos carro de paro SUR y arsenal farmacológico. 59

i. Programas Alimentarios PNAC - PACAM..... 61

j. Protocolos y Procedimientos Complementarios Vigentes. 61

k. Anexo Formato para Acciones de Rehabilitación (Posterior a la contención de emergencia)
Levantamiento de información la realizará COGRID..... 62

l. Ficha Visita Albergues..... 63

m. Glosario 64

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 4 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

1. Presentación

Debido a su especial conformación climática, hidrológica y geotectónica, Chile se encuentra expuesto a distintos tipos de eventos de origen natural, a lo que se suman los crecientes eventos adversos de origen antrópico y resultantes de las dinámicas sociodemográficas. Estos han ocasionado situaciones de emergencias y desastres que han derivado en pérdidas de vidas humanas, afectación de la salud y gran impacto económico. De acuerdo con bases de datos internacionales del Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (CRED), en Chile se registra un aumento exponencial en el número de desastres y se puede pronosticar que en los años venideros nuestro país tendrá al menos un desastre por trimestre¹.

Se agregan a la situación antes descrita las nuevas amenazas asociadas al cambio climático, respecto de las cuales nuestro país es particularmente vulnerable al presentar siete de las nueve características de vulnerabilidad definidas por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, lo que se traduce en que nuestro país se encuentre en una posición notablemente desfavorecida en materia de cambio climático, al ubicarse, según el *Global Climate Risk Index*² del año 2019, en el décimo sexto lugar de los países más afectados por este fenómeno global.

Esta realidad territorial nos desafía como país a transitar desde acciones eminentemente reactivas hacia la gestión integral del riesgo de desastres, caracterizada por una actuación sostenida en función de las distintas fases del ciclo del riesgo: mitigación, preparación, respuesta y recuperación; apuntando al desarrollo de capacidades y reducción de las vulnerabilidades comunitarias e institucionales. Lo que debe hacerse sobre la base de la memoria, los aprendizajes y con profunda pertinencia local.

El cambio climático obliga, además, a introducir en la gestión integral del riesgo el concepto de adaptación, entendido este como el proceso de identificación y diseño de medidas cuyo objetivo se centra en enfrentar y reducir los impactos de eventos asociados al cambio climático cuya frecuencia e intensidad se incrementará con certeza en las próximas décadas y de otros eventos cuya ocurrencia cuenta con escasos registros históricos. Son ejemplos de lo anterior, las olas de calor, la actual mega sequía que se extiende ya por más de 10 años afectando a gran parte del territorio de Chile continental, los aluviones, los tornados, las tormentas de arena y las inundaciones, entre otros eventos climatológicos extremos.

Las situaciones de desastre siempre implican dificultades en la salud pública y en los territorios donde el sector salud debe actuar, según corresponda, conforme al origen, magnitud y consecuencias del evento, para lo cual deberá establecer o reforzar medidas de salud pública, mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica y el control de brotes, garantizar la atención integral y oportuna de las personas y comunidades afectadas de forma inmediata y de acuerdo con sus necesidades.

La experiencia demuestra que la primera respuesta en salud a una situación de emergencia en un territorio específico suele darse por parte de los establecimientos de salud de atención primaria. Las comunidades, los equipos de salud, la misma infraestructura sanitaria, puede verse afectada de diversas formas, aumentando la brecha entre una oferta disminuida y una demanda incrementada y compleja. Todos estos son sucesos que ocurren en un escenario que, con frecuencia, es de desorden y confusión, por lo que, se precisa de una adecuada planificación y preparación.

En ese contexto, considerando los procesos de implementación del Modelo de Atención Integral en Salud (MAISFC), especialmente el alto nivel de vinculación de los equipos de salud con las comunidades (trabajo sectorizado) será fundamental contar con planes de emergencia en cada establecimiento de atención primaria de la red y que su elaboración se realice sobre la base del conocimiento y experiencia del personal

¹ Ministerio de Salud, Lineamiento Temático 2021Eje Emergencias, Desastres y Epidemias. Estrategia Nacional de Salud.
² Elaborado por la organización de medio ambiente y desarrollo Germanwatch en Alemania, la cual es una organización No gubernamental que provee información acerca de adaptación, mitigación y seguridad alimentaria global.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 5 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

de salud y de las organizaciones comunitarias involucradas, apuntando a la reducción del impacto de eventos de emergencias y desastres en los equipos de salud y las comunidades.

El plan de emergencia establecerá las generalidades para abordar la respuesta ante una emergencia y/o desastre interno y/o externo, definiendo la conformación del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRID³ del Establecimiento, los roles de sus integrantes, la forma de trabajar de este, las coordinaciones internas y externas, los flujos de comunicación, entre otros. En consecuencia, cualquier emergencia podrá ser abordada con esta estructura y forma de funcionar como Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRID. Asimismo, y complementariamente este plan llevará en anexos los planes y protocolos específicos de respuesta por variable de riesgo, por ejemplo, procedimientos frente a amenaza de tsunami, sismos, inundaciones, incendios internos o externos, entre otros.

Adicionalmente, la presente guía y formato de Plan de Emergencia propuesto pretende apoyar el cumplimiento a las exigencias de la Acreditación de prestadores, en lo relativo al Plan o Protocolo de Evacuación y Plan de Contingencia en caso de interrupción del suministro eléctrico y de agua potable. Estos planes y procedimientos debieran quedar bajo el alero del plan de emergencias y constituirse en anexos que corresponden a procedimientos específicos.

El contenido del presente documento se elabora bajo un contexto general, de acuerdo con lineamientos y formatos propuestos por ONEMI y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED, anteriormente Sistema Nacional de protección Civil SNPC), lo cual no obsta a introducir nuevos elementos que complementen el actuar sectorial considerando la realidad local de cada establecimiento. Cabe mencionar que en la presente guía y formato los ejemplos descritos son acotados, por tanto, puede haber situaciones que se presenten localmente no contempladas en los ejemplos entregados en este documento.

Para una mejor comprensión del trabajo a realizar con este formato, la “Guía de Elaboración de Planes de Emergencias de Establecimientos de Atención Primaria”, ofrece descripciones y consideraciones del contenido en cada punto con la misma numeración y estructura, de manera de ir acompañando el proceso de elaboración del plan, de acuerdo con la realidad local de cada establecimiento.

³ La Ley 21.634, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, crea el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRID, anteriormente denominado Comité de Emergencia y/o Comité Operativo de Emergencia (COE). La citada ley establece en el “Artículo 5.-Estructuras de Coordinación. Créanse los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ejercerán las funciones propias de cada fase, a nivel nacional, provincial, regional y comunal, según corresponda. En las Fases de Mitigación y Preparación aprobarán los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres que establece esta ley, y coordinarán las instancias necesarias para desarrollar las capacidades y recursos para fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo establecido en el Párrafo 2° del Título I.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 6 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

1.1. Antecedentes

PROPUESTA DE ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO	
Nombre del Establecimiento:	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO
Tipo de establecimiento o Dispositivo <i>(CESFAM, CGU, CGR, PSR, SAPU, SAR, SUR)</i>	CESFAM
Código DEIS	115313
Servicio de Salud	O´HIGGINS
Establecimientos dependientes <i>(según corresponda, Posta de Salud Rural, CESCOSF, SAR, SUR, SAPU, etc.)</i>	SUR, PSR POBLACIÓN, PSR LOS CARDOS, PSR CALLEUQUE, EMR RINCONADA MOLINEROS
Dirección	18 DE SEPTIEMBRE 601
Comuna	PERALILLO
Región	O´HIGGINS
Director/a del establecimiento <i>(Nombres y datos de contacto)</i>	CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA- Mail: c.cardenas@municiperalillo.cl Fono: 722861053
Encargado/a o coordinador/a de emergencias y desastres <i>(Nombres y datos de contacto)</i>	DR. ELIGIO MACHADO RUIZ Mail: emachado@municiperalillo.cl Fono: 722861053
Teléfono Establecimiento <i>(mesa central, horarios de atención y teléfonos alternativos, incluir los prefijos necesarios)</i>	Fono SOME CESFAM: 722336442-953240369 De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Fono SUR: 722336440-953708325 24 horas 7 días de la semana.
Sitio web (si corresponde)	Instagram: @cesfamperalillo
Correo electrónico <i>(si no existe una dirección de correo de contacto con la comunidad, debería usarse el contacto que la dirección designe)</i>	cesfam@municiperalillo.cl
Número total de funcionarios	119
Descripción general del establecimiento <i>(por ejemplo: función en la red, población inscrita, red de establecimientos asociados (tanto de mayor como de menor complejidad), función en emergencias y desastres, etc.)</i>	Del Departamento de Salud de I. Municipalidad de Peralillo depende 1 CESFAM ubicado en el centro urbano de la Comuna, 3 Postas de Salud ubicadas en Sector Población, Los Cardos y Calleuque y 1 Estación Médico Rural en Sector Rinconada de Molineros. También cuenta con un SUR. La población percapitada asciende a 14.286 usuarios validados año 2026. La red de derivación en salud se establece en los casos más complejos de forma directa con Hospital de base que corresponde a Hospital de Santa Cruz. Otros centros de derivación a nivel secundario y terciario lo componen Hospital San Fernando y Hospital Regional. En el caso de la emergencia se fortalecerá la función de SUR, dejando como establecimientos satélites a las postas. CESFAM

	quedará como apoyo ante la emergencia, en modalidad de extensión del SUR hasta que logremos la etapa de rehabilitación.
Distribución Física general <i>(descripción breve del/os edificio/s principal/es. Años de Construcción, Material de la estructura, fechas de normalización si corresponde. Incluya un plano general en esta sección, puede ser un plano de emplazamiento, con la distribución física del establecimiento. Igualmente incluir: Plano de Instalaciones Críticas, con la información por ejemplo de: acometidas eléctricas, empalmes de agua potable, estanque de acumulación de agua potable, grupo o equipos de generación eléctrica de respaldo, empalmes Gas Natural y/o estanque de gas licuado, antena de telecomunicaciones si corresponde, Zonas seguras, entre otras instalaciones críticas que se estime pertinente incluir.</i> <i>De haber planos con mayor detalle pueden dejarse en Anexos, o bien referir la ubicación de estos).</i>	SUR: Este servicio comprende: - 1 sala de tránsito - 1 área de evaluación - 1 sala REA - 1 área administrativa - 1 área de procedimientos/curaciones - 1 sala de descanso TENS - 1 sala de descanso conductores - 3 baños - 1 área de toma de signos vitales - 1 sala de almacenamiento de fármacos y prelavado. Esta unidad está equipada con desfibriladores fijos y automáticos, equipo de resucitación, equipamiento para procedimientos. Su construcción data del año 1981, de material sólido. Demostración sanitaria año 2014. CESFAM: Servicio comprende: - 3 bodegas de farmacia - 1 bodega PNAC-PACAM - 1 Comedor - 1 Sala Esterilización con 2 autoclaves 85 lts - 1 Laboratorio clínico con capacidad para procesar muestras de orina y sangre - 1 Vacunatorio con 2 refrigeradores - 1 Sala IRA - 1 Sala ERA - 4 Baños funcionarios - 1 Baño discapacitados - 1 Box Asistente social - 1 Box Podóloga - 1 Sala de espera principal para máximo de 20 personas. - 1 Sala de box reparto PNAC-PACAM - 1 Sala de box reparto fármacos - 1 SOME centralizado - 1 OIRS - 2 Baños usuarios - 5 box multipropósito tipo 1 - 1 bodega pequeña de útiles de aseo - 1 bodega ropa limpia - 1 box multipropósito tipo 2 - 1 box matrona - 1 bodega pequeña de artículos escritorio - 1 box dental - 1 box TENS Matrona - 1 Sala de espera pequeña máximo 4 personas. - 1 box psicóloga

- 1 box servicios generales
- 1 box digitadora IC-GES- Estadística
- 1 Sala de reuniones
- 1 Sala secretaria de Dirección
- 1 Sala Director con baño incluido.
- 1 Sala REAS en patio CESFAM
- 1 Box toma de signos vitales.
- 1 Área de estacionamiento techado y cementado.

Su construcción data del año 1981, de material sólido. Demostración sanitaria año 2014. A continuación se establece plano de emplazamiento.

Ejemplo: Plano de instalaciones críticas



1. Sala REAS

2. Grupo Electrónico

3. Tablero General Auxiliar
4. Oxígeno

5. Zona de Carga y Descarga

6. Acceso Ambulancias a Sala de Urgencia

7. Suministro de agua autónomo.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 9 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

a. Objetivos

i. Objetivo General

OBJETIVO GENERAL

Objetivos General:

Establecer el quehacer del establecimiento respecto de las estrategias y acciones de alerta, respuesta y rehabilitación en situaciones de emergencias, desastres y epidemias, a fin de proteger la salud e integridad de sus ocupantes y de su comunidad usuaria, resguardando la continuidad operacional para la atención de salud.

ii. Objetivos Específicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir la estructura operativa, roles, funciones específicas y mecanismos de respuesta del establecimiento ante emergencias, desastres y epidemias para asegurar la continuidad de la atención.
2. Impulsar y fortalecer la participación de la comunidad en la preparación, la respuesta y rehabilitación en salud ante situaciones de emergencia o desastre.
3. Incorporar transversalmente en todo el proceso de preparación, respuesta y rehabilitación el componente de salud mental y bienestar psicosocial de la comunidad, así como del personal del centro de salud.
4. Establecer los mecanismos de articulación y coordinación institucional e interinstitucional, definiendo las acciones para las fases de alerta, respuesta y rehabilitación.
5. Identificar amenazas y los riesgos respecto de los cuales se deben desarrollar protocolos y/o procedimientos específicos por variable de riesgo, con focalización en grupos de mayor vulnerabilidad
6. Definir los protocolos y mecanismos de activación y desactivación del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) (anteriormente Comité de Emergencia) del Establecimiento.
7. Identificar los recursos y capacidades existentes y potencialmente disponibles en el Establecimiento de Salud y en la comunidad usuaria, frente a diferentes situaciones de emergencias, desastres y epidemias.
8. Definir los procedimientos para la aplicación de los instrumentos disponibles para evaluar estado del establecimiento y de la comunidad usuaria, ante la ocurrencia de situaciones de emergencias, desastres y epidemias.
9. Definir los protocolos de comunicación, flujos de información, información a la comunidad y medios de comunicación.
10. Evaluar el plan en forma periódica a través de la realización de simulaciones o simulacros.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 10 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

b. Cobertura, Amplitud y Alcance

Cobertura: <i>(Corresponde a la Infraestructura y ocupantes que comprende el establecimiento de Salud. Igualmente se relaciona con la población beneficiaria y territorio que atiende)</i>	En la actualidad el RRHH que comprenden los dispositivos de salud de la Comuna son 119 funcionarios, en su mayoría de género femenino (80% del personal). El 70% de las acciones de salud se concentran en CESFAM Dr. Orlando Leyton A y SUR, considerados como centro madre de la atención comunal, siendo este el dispositivo con mayor resolutiveidad en la Comuna. La infraestructura es insuficiente para realizar atención a las 14.286 personas inscritas. Para subsanar este tema se ha fragmentado la atención en otros espacios facilitados por la I. Municipalidad de Peralillo, sin embargo los dispositivos de mayor complejidad se encuentran en CESFAM. En el caso de las Postas, la mayor en infraestructura corresponde a Población, la cual tiene como infraestructura: 2 box multipropósito, 1 sala de espera, 1 SOME, 1 box matrona y 1 box dental, 1 área de curaciones, 1 entrega de fármacos y leche. Posibilidad de aumentar la superficie operativa con casa anexa, donde existe 1 sala de espera, Comedor, cocina, 2 habitaciones que funciona como box, 1 SALA REAS. Cuenta con equipo electrógeno. Posta Los Cardos tiene menor infraestructura correspondiente a: 1 sala de espera, 1 baño no habilitado, 1 oficina, 1 box procedimientos, 1 entrega de leche y fármacos, 2 box multipropósito y 1 box dental, 1 Sala REAS. Cuenta con equipo electrógeno. En la actualidad con medidas de mitigación en terreno inundable, las cuales no han sido suficientes. Posta Calleque: Posta más pequeña, con infraestructura de: 1 sala de espera, 1 box procedimientos y oficina/ entrega leche y fármacos, 2 box multipropósito, 1 sala REAS. En la actualidad con equipo electrógeno. Terreno inundable. EMR Rinconada de Molineros: EMR pequeña con nula posibilidad de expandirse debido al acotado terreno. 1 Sala de espera, 2 box multipropósito, 1 box TENS.
Amplitud: <i>(Corresponde a las áreas internas del establecimiento que tienen participación y funciones definidas en el Plan (direcciones, departamentos, unidades, etc.)</i>	El presente plan es ejecutado por el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres compuesto por: Jefa de Departamento de Salud, Director CESFAM Peralillo, Jefe Sector Urbano, Jefe Sector Rural (Encargada de dispositivos dependientes), Referente técnico SUR (Encargado/a o Coordinador/a de Gestión del Riesgo de Desastres GRD), Referente administrativo SUR (Enfermera), Referente administrativo de PSCV (Enfermera), Encargados/as de Unidades de Apoyo (SSGG), Encargado/a de Farmacia o botiquín, Encargado/a Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y Programa de Alimentación Complementaria del adulto mayor (PACAM), Encargado/a de Participación Social y Trato al Usuario, Encargado/a Salud Mental, Representante del Comité Paritario.
Alcance: <i>(Considerar todas las condiciones que puedan superar la capacidad de respuesta del establecimiento)</i>	El presente plan, considerando las condiciones de riesgo y vulnerabilidad locales, define su ejecución en situaciones de emergencias, desastres y epidemias que, por su magnitud, nivel de afectación a las personas, bienes y medioambiente, superen la capacidad de respuesta y del funcionamiento normal del establecimiento de salud. Se adjuntan a este plan los protocolos o procedimientos complementarios por variable de riesgo, como por ejemplo: Plan de contingencia por interrupción de suministro eléctrico, Plan de evacuación (en caso de sismo, incendio), Plan de emergencia ante incendios forestales, Código Azul.

c. Relación con Otros Planes

LISTADO DE PLANES CON LOS CUALES SE RELACIONA EL PLAN DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO
Plan Nacional de Emergencia
Plan de Emergencias del Sector Salud (Nivel central)
Plan de Emergencia del Servicio de Salud respectivo
Plan de Emergencia Comunal

8. Levantamiento de Recursos y Capacidades Institucionales y de la Comunidad

RECURSOS Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES						
La presente es una propuesta de formato de recursos y capacidades que puede ser modificada en torno a consignar recursos y capacidades de acuerdo con la realidad local del establecimiento:						
1. Recursos Humanos						
Personal	CESFAM	SUR	Postas	Otros Dispositivos	Total dotación	
					Mujer	Hombre
Total de personal horario hábil <i>(considerar a todo el personal inclusive trabajadores de empresas en régimen de subcontratación, personal de aseo, seguridad, alimentación, etc.)</i>	62	6	22	10	82	18
Total de personal en horario inhábil y/o extensión horaria y urgencia	4	4	0	0	5	2
Personal Capacitado PAP (Primera Ayuda Psicológica)	3	0	0	0	3	0
Personal Capacitado RCP (Reanimación Cardiopulmonar)	62	6	22	10	82	18
Personal capacitado en uso de extintores	40	8	5	0	40	13
Personal capacitado en gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres	2	2	0	0	1	3
Personal capacitado en salud mental en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)	3	0	0	0	3	0
Personal capacitado en temáticas afines, por	0	0	0	0	0	0

ejemplo: facilitador/a intercultural.						
Personal capacitado en radiocomunicaciones	3	0	0	0	0	3

Individualización de trabajadores o trabajadoras con discapacidad: *El presente cuadro puede ser agregado en los anexos para la identificación de las personas con discapacidad.*

Nombre completo	Género	Edad	Tipo de Discapacidad	Lugar/servicio donde labora o permanece habitualmente	Necesita ayuda para movilizarse, leer, escuchar o comprender información en caso de evacuación	Uso de dispositivo de ayuda	Necesidad específica para comunicarse

2. Dotación de box de atención, sala de procedimientos y posibilidades de aumento de capacidad de estos.

2.1. Box o Salas de Atención CESFAM *(el siguiente cuadro es referencial y debe ser adaptado a la realidad del establecimiento)*

Tipo de Box	Cantidad de cupos por box o sala	Número máximo de cupos para situaciones de emergencias y desastres	Observaciones
Box multipropósito	5	5	
Sala de atención ginecológica con baño	1	1	
Sala de atención de urgencia y reanimación	1	1	
Sala de Procedimientos y Cirugía Menor	1	1	SOLO PROCEDIMIENTOS
Salas de Curación y tratamiento	1	1	UBICADA EN SUR
Salas de atención respiratoria (IRA-ERA)	2	2	
Box de dispositivos dependientes (SAR, SUR, SAPU, Posta, etc.)	1	1	SUR
Sala de Rehabilitación/Fisioterapia <i>Indicar si cuenta con cupos de gases clínicos, por ejemplo 2.</i>	0	0	FUERA DE RANGO CESFAM
<i>Casa Salud Mental</i>	4	4	Oficinas o contención psicológica
Total	16	16	

3. Servicios de apoyo clínico y de otro tipo (listado de los servicios con que cuenta el establecimiento e indicar alguna observación respecto de su capacidad si corresponde, por ejemplo, Farmacia cuenta con stock de medicamentos para 30 días)

Departamento, Unidad o Servicio	Observaciones
Laboratorio	CESFAM cuenta con laboratorio para procesamiento de muestras orina y sangre.
Farmacia	Stock de arsenal farmacológico para abastecer por lo menos 2 meses la atención.
Programas de Alimentación PACAM, PNAC	Stock de leche y productos alimentarios para abastecer 2 meses la atención
Esterilización	CESFAM cuenta con unidad de esterilización, 2 autoclaves de 85 lts cada uno de capacidad
Vacunatorio	CESFAM cuenta con 2 refrigeradores para resguardo de vacunas. Además 1 refrigerador no frost en SUR
Sala de Acopio transitorio de Residuos.	CESFAM cuenta con Sala REAS habilitada con autorización sanitaria vigente. Posta Población, Los Cardos y Calleuque cuentan con Sala transitoria de residuos. El acopio es para máximo 1 semana.
Movilización	Contamos con 3 ambulancias básicas operativas, 2 furgones para movilización de funcionarios, 2 camionetas 4x4 y 1 automóvil para visitas en domicilio.

4. Áreas susceptibles de aumentar la capacidad operativa. Indique las características de los lugares, áreas y espacios que puedan utilizarse para aumentar la capacidad del establecimiento en caso de emergencias y desastres. Especifique el área en metros cuadrados, los sistemas esenciales disponibles y cualquier otro dato que pueda servir para evaluar la conveniencia de ampliar el espacio y la capacidad de los servicios médicos y de otro tipo en emergencias y desastres. Incluya acceso, vigilancia, protección y servicios esenciales, como agua, electricidad, comunicaciones, gestión de residuos, calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Lugares y área	Superficie m2	Agua Potable	Energía eléctrica	Teléfonos y comunicaciones	Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado	Gestión de Residuos	Ubicación y función: <i>Indicar la ubicación del área que tipo de función cumplirá el área y su capacidad. Por ejemplo, Triage, atención ambulatoria, observación, área transitoria para disposición de cadáveres en caso de emergencias o desastres, etc.</i>
		SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	
Box multipropósitos (5)	12	SI	SI	SI	NO	SI	Box para prestaciones médicas ante la emergencia
SOME	25	SI	SI	SI	SI	NO	Área de intercomunicaciones
Entrega de fármacos	40	SI	SI	SI	SI	SI	Entrega de medicamentos
Entrega de leche	25	SI	SI	SI	NO	SI	Entrega de leche

Sala de espera principal	40	SI	SI	SI	SI	NO	Zona de procedimientos (habilitarlo con camillas de box no usados)
Sala de reuniones	25	SI	SI	SI	NO	NO	Lugar para fallecidos
Vacunatorio	20	SI	SI	SI	SI	SI	Vacunas

5. Líneas Vitales⁴ *(considerar el funcionamiento del establecimiento al 100% de su capacidad)*

Líneas Vitales	Autonomía horas	Respalda el 100% del establecimiento (SI/NO)	Si no respalda el 100% del establecimiento, qué sectores <u>NO</u> están respaldados
Agua Potable	120	SI	
Electricidad	12	SI	

Gases clínicos	Autonomía horas	Proveedor	Contacto proveedor
Oxígeno	NO	NO	SÓLO SE CUENTA CON BALONES DE OXÍGENO (2 GRANDES Y 6 PEQUEÑOS)
Aire Medicinal	NO	NO	NO
Otros: Concentradores de oxígeno			2 CONCENTRADORES DE OXÍGENOS PORTÁTILES

Sistemas de Climatización y Acondicionamiento de Aire (ventilación, filtraje, calefacción, enfriamiento, etc.)	Cuenta con el sistema o equipo (SI/NO /PARCIALMENTE)	Indicar sector, área o recinto que cuenta con el sistema o equipo.
AIRE ACONDICIONADO	PARCIALMENTE	EN SALA DE ESPERA PRINCIPAL CESFAM, SALA DE ESPERA SUR, SALA TRANSITO SUR, SALA ESPERA ANEXO CESFAM, LABORATORIO, ESTERILIZACIÓN, VACUNATORIO, FARMACIA, SOME.

⁴ Algunas de las definiciones contenidas en la Norma Técnica N°3 de MINVU que es el antecedente de la norma chilena 3359, establecen los siguientes parámetros: Los establecimientos de atención primaria son definidas como estratégicas: “Es aquella edificación donde funcionan y operan instalaciones de utilidad pública necesarias en la recuperación de la normalidad posterior a un sismo o evento de gran magnitud, y que deben permanecer en funcionamiento durante y después de dicho evento”. Asimismo, indica que lo requisitos para estas edificaciones son: autonomía de agua potable, autonomía eléctrica total y sistema integral de protección contra incendios, cuyas definiciones son las siguientes:

- Autonomía de agua potable: Disponibilidad de un sistema que incluya estanques de acumulación para provisión de Agua Potable para consumo del establecimiento al 100% de su capacidad por 48 horas.
- Autonomía energética total: Capacidad de dotar de energía para la normal operación del 100% de las instalaciones del edificio durante 72 horas, por medio de equipos de emergencia autónomos como grupos electrógenos, equipos eólicos, y otros que puedan existir. Además, se debe contar con aprovisionamiento de combustible para operar los equipos en este período.
- Sistema integral de protección contra incendios: sistema de protección contra incendio tales como red seca, red húmeda, extintores, rociadores y otros, en todos los niveles o pisos del edificio y con una cobertura tota por planta.

CALEFACCIÓN A GAS	PARCIALMENTE	BOX DE ATENCIONES Y BODEGAS.

6. Telecomunicaciones, radiocomunicaciones y Plataformas de información *(Radio comunicación, telefonía satelital, telefonía celular, antenas, bases de radio, dispositivos, entre otra información relevante que deje claramente establecidos los recursos y capacidades en esta materia)*

Por ejemplo:

Tecnología	Sistema	Operativo – cuenta con mantenimiento (SI/NO)	Descripción	Cobertura	Amplitud
Radio Comunicación	VHF	SI	Sistema de comunicación utilizado de manera externa e interna, como soporte comunicacional y de coordinación con SAMU y entre Postas con SUR	Regional/Comunal	Conectada con HSC, Bomberos, Seguridad ciudadana y Postas
Telefonía	Móvil	SI	Sistema de comunicación utilizado de manera interna y externa	Nacional	Director/a Encargados o jefes/as de sector, SUR, SOME
Alto Parlantes u otros sistemas de voceo	Voceo y altoparlante	SI	Sistema de comunicación utilizado de manera interna	Establecimiento	Salas de espera y pasillos del establecimiento

7. Recursos Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID)

Sala de crisis o de situación (Comité de Gestión del Riesgo de Desastres)	
Ubicación	Dirección CESFAM
Ubicación alternativa	Comedor CESFAM
Equipamiento y mobiliario disponible o posible de habilitar <i>(indicar computadores, telefonía, mesas de reuniones, etc.)</i>	1 notebook
	1 mesa
	Posibilidad de habilitar con 6 sillas individuales
	1 Data
	Red eléctrica e internet

8. Recursos Logísticos de Transporte

Vehículo	Cuenta con SI/NO	Descripción	Operativa SI/NO	Observación
Ambulancia de transporte <i>(indicar nivel de complejidad.</i>	SI	AMBULANCIA DE NIVEL BÁSICO PARA	SI	3 AMBULANCIAS

<i>Agregar la cantidad de líneas que corresponda)</i>		TRASPORTE DE USUARIOS A CENTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD		
Cuentan con recursos para habilitar la ambulancia de transporte en medicalizada.	NO			
Vehículo transporte simple	SI	2 MINIBUS PARA TRASPORTE	SI	
Camionetas	SI	2 CAMIONETAS 4X4	SI	
Cuenta con acceso a Aero-evacuación	NO			
<i>Otros (por ejemplo, compra de servicios)</i>				

9. Recursos para detección y Control de Incendios

Equipo/Sistema	Cuenta con SI/NO	Descripción	Ubicación <i>(indicar Servicios, Unidades y Secciones)</i>	Operativa SI/NO	Observación
Sistemas de detección de incendios, humo, alarmas, sensores, etc.	NO				
Sistemas de Extinción activo: Extintores tipo ABC o D <i>(singularizar por tipo de extintor y se sugiere anexar plano de la ubicación de estos)</i>	SI	CESFAM CUENTA CON EXTINTORES TIPO BC Y ABC.	EN TODO EL ESTABLECIMIENTO	SI	SE DESCRIBE DISPOSICIÓN Y LUGARES EN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN INCENDIOS
Red Húmeda	SI	PUNTOS ESTRATEGICOS DE CESFAM	EN TODO EL ESTABLECIMIENTO	SI	REDES OPERATIVAS CAMBIADAS 2023
Red Seca	NO				

Luces de Emergencia	SI	LUCES DE EMERGENCIA	SUR, PASILLOS INTERNOS CESFAM	SI	
Otros					

10. Señalética y Sistemas para la Evacuación

Corresponde a todas aquellas señales y alarma con que cuenta la edificación que permite identificar las vías de evacuación, las zonas seguras exteriores, las zonas seguras interiores del establecimiento, entre otra señalización importante para la evacuación del edificio. Indicar si cuenta con señalética para personas con Discapacidad y el tipo de esta. (En pavimentos, luminosas, auditivas, táctiles, etc.)

Sistemas para la evacuación	¿Cuenta con señaléticas? SI/NO	¿Cuenta con señalética específica para personas con discapacidad? SI/NO	Tipo de señalética para personas con discapacidad (sonora, lumínica, audible, pictograma de síntesis, etc.)
Vías de evacuación	SI	NO	SEÑALÉTICA
Salidas de escape	SI	NO	SEÑALÉTICA
Zonas de seguridad exteriores	NO		
Zonas de seguridad interiores	NO		
Otra			

Sistema de Alarma para la evacuación	Alarma sonora para indicar evacuación, sistema de altoparlante.
--------------------------------------	---

11. Capacidades de la Comunidad, por ejemplo: agentes comunitarios capacitados en salud y Gestión del Riesgo de Desastres.

Capacidad	Descripción
ABC emergencia	Comunicación directa con bomberos y carabineros vía VHF y celulares.
Comité de emergencia comunal	Comunicación directa con equipo de emergencia comunal vía whatsapp grupal y celulares.

12. Otros, En este punto se sugiere agregar otros recursos y capacidades que se consideren útiles para la respuesta a emergencias y desastres. Por ejemplo: convenios con universidades u otras del intersector local.

Capacidad	Descripción

9. Coordinación

a. Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID)

COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COGRID) (anteriormente Comité de Emergencia)	
El Comité de Gestión del Riesgo de Desastres del establecimiento, es la entidad a cargo de coordinar las acciones en la fase de preparación, alerta, respuesta y rehabilitación del establecimiento ante emergencias, desastres y epidemias. Su constitución se ejecuta en tiempos de normalidad o durante la respuesta a situaciones de emergencias desastres y epidemias, según sea pertinente. Debe establecer reuniones periódicas y un plan de trabajo en la gestión del riesgo de desastres en las distintas fases de la emergencia y/o desastre, que incorpore la creación y actualización del plan de emergencias del establecimiento, así como los procedimientos o protocolos por variable de riesgo, los que se describen más adelante. El Comité de Emergencias del establecimiento está formalizado a través de la siguiente Resolución Exenta, la cual define sus objetivos y sus integrantes.	
Orden Administrativa N°	23 DEL 3 DE ENERO DE 2022 y sus actualizaciones posteriores.
Se deberá considerar, el resguardo de estos roles en horarios hábiles y no hábiles y también subrogancias o reemplazos en caso de permisos, licencias y/o feriado legal de los integrantes. En el caso de que la situación lo amerite, y de acuerdo con la coordinación administrativa del establecimiento, los integrantes titulares del comité de gestión del riesgo de desastres deberán asistir en horarios inhábiles, y en días festivos. Esto conforme a la convocatoria y autoconvocatoria que se describe en el punto siguiente.	
CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COGRID) EN HORARIO HÁBIL E INHÁBIL	
COGRID – lunes a domingo en horario hábil e inhábil	Subrogante/Reemplazo
Jefa de Departamento de Salud	Jefa de Departamento de Salud (s)
Director/a del establecimiento	Director Subrogante según OA
Jefatura de Sector Urbano	Jefatura de Sector Urbano (s)
Jefatura de Sector Rural	Jefatura de Sector Rural (s)
Coordinador GRD (Referente técnico SUR)	Referente técnico SUR
Referente administrativo SUR	Referente administrativo SUR (s)
Referente administrativo PSCV	Referente administrativo PSCV (s)
Encargado de unidades apoyo (mantenimiento)	Encargado de informática
Encargado de Farmacia	Encargado de Farmacia (s)
Encargado Programa Alimentario	Encargado Programa Alimentario (s)
Encargada participación ciudadana	Encargada participación ciudadana (s)
Encargada Salud Mental	Encargada Salud Mental (s)
Representante Comité Paritario	Representante (s) Comité Paritario

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 19 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

i. Activación, Convocatoria y Auto Convocatoria

ACTIVACIÓN	
Qué tipo de señal y/o mecanismo se usará para la activación:	Comunicación de los integrantes vía whatsapp grupal
Procedimientos de activación fuera del horario hábil y en fines de semana o festivos:	Mensaje whatsapp

CONVOCATORIA	
Eventos que ameritan convocatoria:	<i>Cuando se ve superada la capacidad de respuesta local y/o tiene alta connotación pública y que requiera una respuesta bajo la estructura de comité de gestión del riesgo de desastres: Incendios forestales, alta cantidad de personas allegadas por fenómenos climáticos. Convoca: Jefa de Departamento o director/a del Establecimiento o el Coordinador/a de Emergencias y Desastres, por instrucciones del director/a del Establecimiento o quien lo subroge.</i>

AUTOCONVOCATORIA	
Eventos que ameritan Autoconvocatoria: <i>La indicación de concurrir a un lugar previamente establecido ante un evento de tipo y características definidas y no exista posibilidad de comunicación. Debe definirse detalladamente el tipo y características de un evento en que amerita la autoconvocatoria, conforme la matriz de riesgos o amenazas locales identificadas para el establecimiento o la población que atiende. Debe definirse también el lugar primario donde se reunirá el comité y su alternativa, en el caso que el lugar primario establecido no pueda ser utilizado.</i>	<i>Ante casos de máxima gravedad: Incendios en el propio establecimiento. Ante un evento sísmico de gran intensidad y/o magnitud, (grado VII o superior en la escala sismológica de Mercalli), los miembros del Comité de Emergencias se deben autoconvocar sin necesidad de que medie una convocatoria formal emanada del Coordinador/a de Emergencias y Desastres o el Director/a del Establecimiento, constituyéndose como Comité de gestión del riesgo de Desastres (COGRID). El sitio de reunión para la autoconvocatoria es la oficina de Dirección de CESFAM y el sitio alternativo para esta convocatoria es el comedor de funcionarios.</i>

ii. Definición de Roles y Funciones.

DEFINICIÓN DE ROLES Y FUNCIONES		
Se recomienda que las funciones que realiza individualmente cada uno de los miembros del COGRID en representación del sector o Unidad correspondiente estén definidas en las Tarjetas de Acción de acuerdo con el formato indicado en el Anexo 8.6.		
A modo de ejemplo para el establecimiento:		
Integrante	Rol	Funciones
Jefe de Departamento de Salud	Mando Autoridad	• Informar a autoridades superiores sobre el trabajo ante la emergencia. • Generar las solicitudes de recursos necesarios a Instancias superiores. • Informar a la opinión pública y prensa. • Convoca COGRID
Director/a	Jefe/a de la Emergencia Mando Autoridad	• Preside el COGRID • Convocar al COGRID • Se encargará de poner en operación el Plan de Emergencia del Establecimiento. • Definir la instrucción de evacuación parcial o total del establecimiento. • Autorizar al coordinador/a de emergencia ejecutar los procedimientos que le corresponden de acuerdo con el Plan de Emergencia. • Tomar las decisiones conforme la información aportada por los mandos técnicos como subdirecciones y áreas respectivas. (áreas clínicas, áreas de apoyo clínico, áreas administrativas, áreas de personal, etc.) • Dar la orden de cesar o suspender determinadas actividades: Urgencia, Consultas, entrega de fármacos, vacunatorio, etc. acorde con la emergencia.
Referente técnico SUR- Coordinador/a de Emergencias y desastres	Coordinación del COGRID Mando Coordinación	• Convocar al COGRID previa autorización de Jefa de Departamento o Director de CESFAM. • Realiza reporte general de emergencia plataforma MIDAS. • Coordinar las áreas relacionadas a acciones de respuesta ante emergencias y desastres. • Establecer contacto con la coordinación de emergencia del Servicio de Salud, Seremi de Salud y Municipio correspondiente, para las acciones necesarias. • Coordinación con instituciones de apoyo a la emergencia, por ejemplo: bomberos, carabineros, empresas de servicios básicos como: sanitarias, eléctricas, combustibles, gases clínicos, etc. Esta función también la podrá realizar según contexto local SECRETARIA DE DIRECCIÓN.
Referente administrativo SUR	Mando Coordinación	• Recopilar y consolidar información de las distintas áreas del establecimiento, para la generación de Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN, instrumento disponible en Plataforma MIDAS – Módulo de Emergencias). • Coordinar acciones de Salud Mental y psicosociales para el personal y la población afectada, en base al Modelo de Protección de la Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Desastres. • Entregar información COGRID a SUR. Reportar problemas en esta área a Director
Referente administrativo PSCV	Mando Técnico	• Entregar al COGRID el listado de los pacientes en atención, así como su estado. • Evaluación e Información de la Capacidad de Atención y prestaciones asociadas, por ejemplo, capacidad de cupos de atención, de acuerdo con los tipos de box o salas existentes, salas de procedimientos, salas de curación, etc.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 21 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

Jefatura de sector Urbano	Mando Técnico	- Instrucción de las decisiones tomadas en el COGRID a funcionarios de Sector Urbano. - Organizar la unidad administrativa SOME - Coordinar con los responsables correspondientes, la evacuación parcial o total del edificio de acuerdo con la decisión del Jefe/a de Emergencia (director/a) y de acuerdo con el Plan de Evacuación del establecimiento - Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación. - Evaluación de necesidades respecto de este ámbito
Jefatura de Sector Rural	Mando Técnico	- Instrucción de las decisiones tomadas en el COGRID en sector rural. - Coordinar según indicaciones de COGRID la conformación de las cuadrillas que saldrán a Postas. - Evaluación de necesidades respecto de este ámbito. - Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación.
Jefaturas o Encargados/as de Unidades de Apoyo-Mantenimiento	Apoyo Técnico	- Deberá reportar estado de la infraestructura, líneas vitales, equipos y equipamiento, así como las líneas de acción propuestas y las necesidades respecto de este ámbito. - Mantenimiento de conexión internet, generadores, habilitación de agua potable.
Encargado/a de Farmacia	Apoyo Técnico	- Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación. - Informar stocks críticos - Organizar equipo de trabajo en Farmacia y Bodega - Evaluación de necesidades respecto de este ámbito
Encargado/a PNAC y PACAM	Apoyo Técnico	- Informar listado de funcionarios/as y áreas a su cargo y estado de situación. - Organizar equipo de trabajo programa alimentario.
Encargado/a Salud Mental	Apoyo Técnico	- Evaluación de daños y necesidades del área de salud mental de la comunidad usuaria. - Activación de Protocolo de PAP para la comunidad usuaria. - Propuestas de líneas de acción de apoyo a la comunidad, con foco en población de mayor situación de riesgo y vulnerabilidad. - Coordinación de acciones intersectoriales necesarias para fortalecer el apoyo a la comunidad usuaria - Contención a funcionarios/as - Completar EDAN Salud Mental.
Encargado de Participación y Trato al Usuario	Apoyo información	- Establecer un sistema para la información a familiares. - Velar por la accesibilidad de la información de forma inclusiva. - Sociabilizar el plan de emergencia institucional con CDLS y otras organizaciones sociales de la Comuna. - Proporcionar bases de datos de actores sociales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la gestión de los establecimientos de salud.
Representante de CPHS	Apoyo Técnico	- Verificar daños de extintores, red húmeda. Despejar zonas de evacuación interna y zonas de seguridad externa. - Comunicar a Director sobre daños de esta índole y acciones a seguir.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 22 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

b. Coordinación Institucional

i. Fase Alerta

FASE ALERTA	
Se deberá establecer el modo de alertar en el caso de una emergencia interno o externa al establecimiento.	
Alerta en caso de emergencia interna:	- Cualquier funcionario/a conoce una anomalía o una emergencia ya sea en forma personal o por aviso de un usuario/a. - El/la funcionario/a informa inmediatamente a Dirección CESFAM al citófono 204-205. La persona debe indicar el nombre, el tipo de emergencia y el área afectada. - El/la funcionario/a toma su lugar según el plan y sigue las instrucciones de este, ya sea para acción autónoma inmediata o espera de confirmaciones y alarmas si corresponde. - En el caso de horario inhábil se debe llamar a Celular de Director CRISTIAN CARDENAS ESPINOZA/CELULAR: 995415368 o bien al médico de turno en Servicio de Urgencia Rural.
Alerta en caso de emergencia externa:	- El/la funcionario/a que recibe la primera información deberá recopilar al menos los siguientes datos: - Nombre del Informante - Lugar desde donde llama - Ubicación exacta del lugar de la emergencia - Cuál es la situación que se está presentando - En la medida de lo posible, deberá informar, además: - Estimación del número de afectados - Tipo de lesiones: graves, menos grave, vitales. - Organismos extrahospitalarios presentes que pueden concurrir en la escena de la emergencia - El/la funcionario/a notifica directamente a su jefatura tanto para horario hábil e inhábil, en caso de no ser posible, lo hace directamente en el siguiente número: CRISTIAN CARDENAS ESPINOZA/CELULAR: 995415368 o bien al médico de turno en Servicio de Urgencia Rural. - El/la funcionario/a toma su lugar según el plan y sigue las instrucciones de este, ya sea para acción autónoma inmediata o espera de confirmaciones y alarmas si corresponde.

ii. Fase Respuesta

FASE DE RESPUESTA		
Levantamiento de información. Para el levantamiento de información es importante considerar a la comunidad y organizaciones sociales, entre otras, como un apoyo en estos levantamientos. Considerar dentro de la gestión de la información, el uso de la Plataforma MIDAS⁵, Módulo de Emergencias, de manera coordinada con el Servicio de Salud, considerando las orientaciones oficiales en la materia (Circular 18 de 2018 del Ministerio de Salud).		
Instrumento	Contenidos	Fuentes de Datos
Reporte General de Emergencias (Anexo 8.4)	- Tipo de evento - Ocurrencia (fecha y hora) - Origen de la información - Dirección y/o ubicación - Descripción del evento - Impacto en las personas (heridos/fallecidos) - Población en riesgo - Riesgo para la seguridad del personal institucional - Capacidad de respuesta - Disponibilidad de recursos para atender la emergencia - Acciones	Este informe debe ser elaborado por el Coordinador de Emergencias y Desastres de SEREMI y/o Servicios de Salud, en coordinación con el municipio si corresponde, según sus respectivos ámbitos de acción, con la información proporcionada por los organismos respondedores (Bomberos, Equipo de la SEREMI de Salud en terreno, Carabineros, etc.) y deberá ser remitido por medio oficial en el evento correspondiente en Módulo de Emergencias MIDAS, dirigido a las autoridades, DEGREYD y referentes técnicos locales, según corresponda, antes de las primeras 8 horas, y puede ser complementado con posterioridad. En caso de caída del sistema el Reporte del Establecimiento debe ser enviado vía correo electrónico al Coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud y Coordinador de emergencias del Municipio si corresponde, con copia al Coordinador/a de Emergencias y Desastres de la SEREMI de Salud y al Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud. En caso de pérdida tanto de internet como intranet, se debe utilizar el EDAN correspondiente para comunicaciones radiales, a través de los sistemas HF, VHF y/o satelitales con que se cuente, informando tanto al Coordinador de Emergencias y desastres del Servicio de Salud como al Director de Salud o Encargado de Emergencias del Municipio.
EDAN Establecimientos de Salud (Anexo 8.5.1)	- Descripción de la situación - Afectación del establecimiento - Impacto en los funcionarios y/o usuarios, incluido impacto psicosocial. - Daños estructurales y no estructurales	Este informe debe ser completado por el encargado de Emergencias y Desastres del Establecimiento debe ser elaborado dentro de las primeras 2 horas de ocurrido un evento adverso, o con posterioridad a la sesión del COGRID. La información

⁵ Modernización de Información Digital de la Autoridad Sanitaria

	• Afectación en las líneas vitales • Funcionamiento de programas y servicios clínicos • Consultas asociadas al evento • Necesidades y requerimientos para garantizar la continuidad de la atención • Principales medidas adoptadas	entregada debe corresponder a una evaluación preliminar realizada en terreno, y de acuerdo con lo informado en el COGRID realizado en el establecimiento, con participación de los actores que constituyen el COGRID En caso de caída del sistema el EDAN del Establecimiento debe ser enviado vía correo electrónico al Coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud y encargado correspondiente del Municipio, con copia al Coordinador/a de Emergencias y Desastres de la SEREMI de Salud y al Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud. En caso de pérdida tanto de internet como intranet, se debe utilizar el EDAN correspondiente para comunicaciones radiales a través de los sistemas HF, VHF y/o satelitales con que se cuente.
EDAN SALUD MENTAL (Anexo 8.5.2)	• Impacto del Evento en la Comunidad • Factores de riesgo asociados a la respuesta • Factores de vulnerabilidad previos en la comunidad/territorio • Factores protectores previos y post evento • Recursos Disponibles (por ejemplo, personal con formación en salud mental en emergencias y desastres, PAP, etc.) • Listado de necesidades psicosociales, institucionales, básicas • Síntesis de necesidades prioritarias (diferenciadas de acuerdo con necesidades de grupos vulnerables) • Acciones en salud mental y Apoyo Psicosocial realizadas y planificadas (diferenciadas por grupos vulnerables)	Este instrumento deberá ser aplicado considerando como unidad de análisis fundamental el territorio asignado a un dispositivo de atención primaria (CESFAM u Hospital Comunitario), durante las primeras 72 Horas después de un evento adverso de gran impacto (en general niveles III o IV). Debe ser completado por al menos un profesional de salud mental del establecimiento en conjunto con otros integrantes del equipo de salud y puesto en conocimiento del director del Establecimiento. Se construirá mediante la observación directa y recolectando información proveniente de los actores claves de la comunidad, de la red de salud, de organismos del intersector, por lo que podrá realizarse posterior al análisis hecho en la primera reunión del COGRID y/o luego de la Mesa Técnica de Salud Mental en Emergencias o similar. Considerando la relevancia de la información y análisis del EDAN de salud mental, éste debe ser puesto a disposición en: - Módulo de Emergencias de la Plataforma MIDAS (durante las primeras 72 Horas), para que puedan acceder a este: referentes de salud mental y de emergencias y desastres de Servicios y SEREMI de salud, nivel central MINSAL, así como autoridades y otros tomadores de decisión del sector salud.

		- Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID)
• Activación y despliegue de recursos y capacidades. La activación y despliegue (reconversión de lugares) dependerá del tipo de emergencia, magnitud e impacto de ésta. • Coordinación de acciones de respuesta. En general las líneas de acción de la respuesta son concordantes con la evaluación de daños y necesidades realizada de acuerdo con el evento. En esta etapa se ponen en curso las acciones definidas en tarjetas de acción de los integrantes del comité de emergencia y otros actores relevantes para la respuesta. Se ejecutan las acciones establecidas en el COGRID como líneas de acción. Igualmente se pone en práctica los flujos de comunicación e información.		
Líneas de acción que deben contemplarse <i>La respuesta será de acuerdo con el tipo de evento que se desarrolle, por lo cual se recomienda la elaboración de protocolos por variable de riesgo, de acuerdo con lo sugerido en Anexo 8.9.</i>	• Describir el funcionamiento y operación del establecimiento en la emergencia y/o desastre. • Vigilancia epidemiológica. • Servicios, líneas vitales, suministros básicos, Infraestructura, equipos y equipamiento. • Bienestar y cuidado del equipo de salud. Por ejemplo: Primera Ayuda Psicológica (PAP) para personas que lo requieran, activación de protocolo PAP en los establecimientos que exista. • Comunicaciones internas. • Información a la comunidad - En esta acción se debe considerar la función que pueden cumplir las redes, organizaciones y actores relevantes de los territorios, por ejemplo, Juntas de Vecino como medio para la bajada de información en sus territorios. • Información a medios de comunicación. • Coordinación interinstitucional. • Protección de la salud mental de la comunidad. Apoyo psicosocial para grupos mayormente afectados por el evento y a grupos específicos, que puedan presentar necesidades particulares. • Visita y atención de salud en Albergues en el caso que se deba entrar atención de salud en estos. En Anexo N°14 se propone una ficha para esta línea de acción. • Otras necesarias para la respuesta.	

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 26 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

Fin de la Emergencia

Considerar el fin de la emergencia, cuándo y cómo se establece que la emergencia ha finalizado. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la atención de pacientes y prestación de servicios. Igualmente se deberá notificar el fin de la emergencia a los niveles superiores correspondientes, como Servicio de Salud y Municipio.

iii. Fase Rehabilitación

REHABILITACIÓN

Implica todas aquellas acciones destinadas a reestablecer la capacidad operativa del establecimiento, de acuerdo con la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN y EDAN de Salud Mental) ya realizada. Estas acciones de la fase de rehabilitación necesariamente tendrán un tiempo asociado para su desarrollo, así como también costos y responsables. Por tanto, la descripción de estas acciones lo más detalladas posible será fundamental para los informes a las autoridades correspondientes. Operativamente, se recomienda el uso del formato establecido en el Anexo 8.12.

En esta sección es importante considerar las acciones o coordinaciones para la rehabilitación referentes a:

- **Elementos Estructurales** de la edificación si han sido afectados. (se deberá evaluar si es posible su recuperación y la estrategia para ello)
- **Elementos Arquitectónicos:** puertas, ventanas, revestimientos, techos, barandas, escaleras, circulaciones interiores, circulaciones exteriores, tabiques, cielos falsos, muros perimetrales, cornisas, letreros, ascensores, rampas, pavimentos, etc.
- **Protección, acceso y seguridad física de la infraestructura:** salidas de emergencia, vías de evacuación, sistemas de emergencia, vigilancia, entre otras.
- **Líneas vitales:** sistemas eléctricos, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de suministro de agua potable, sistema de protección contra incendios, sistema de gestión de residuos, sistemas de almacenamiento de combustibles, sistemas de gases medicinales, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- **Equipos y Suministros:** mobiliario y equipo de oficina y para almacenes, estanterías. Equipos y suministro médicos en las distintas unidades o establecimientos dependientes del establecimiento (SUR, Postas, farmacia, esterilización, áreas clínicas, etc.) Equipos de soporte vital: resucitadores manuales, monitor de signos vitales, DEA, otros equipos de soporte vital, etc.
- **Vehículos:** Ambulancia de transporte, si cuentan con recursos para habilitar la ambulancia de transporte en medicalizada, vehículo transporte simple, camionetas, otros.
- **Restablecimiento de operatividad de los sectores clínicos y recintos de apoyo** (infraestructura, recursos humanos, etc.)
- **Acciones de Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Desastres** para funcionarios y usuarios que lo requieran. (Modelo de Protección de Salud Mental en la GRD.)

c. Coordinación Interinstitucional

i. Fase Alerta, respuesta y rehabilitación

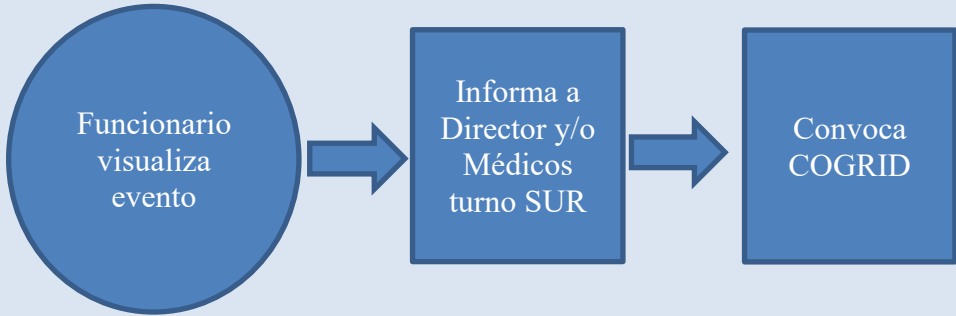
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - FASE ALERTA, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN			
Institución / Entidades / Organismos	Coordinaciones en Fase Alerta	Coordinaciones en Fase Respuesta	Coordinaciones en Fase Rehabilitación
Bomberos/Carabineros	X (Según tipo de emergencia)	X	
Proveedor de Agua Potable		X	X
Organizaciones Comunitarias			X
Proveedor Electricidad	X (Según tipo de emergencia)	X	X
Proveedor Gases Clínicos	X (Según tipo de emergencia)	X	X
Proveedor de combustibles (gas, Diesel, etc.)		X	X

10. Comunicación e Información

a. Sistema de Telecomunicaciones

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES		
<i>Deberá describir cuales son los sistemas y flujos de comunicación. Considerando la información aportada en el punto 2 de Levantamiento de recursos y capacidades se deberá describir cómo y quienes operan el sistema de altavoz, telecomunicaciones y radiocomunicaciones si lo hubiera, conforme al ejemplo:</i>		
Sistemas	Descripción	Quién lo opera
Telefonía	<i>El establecimiento cuenta con un sistema telefónico a través de anexos en forma interna, que permite una comunicación directa con las oficinas y dependencias del establecimiento y en forma externa con los servicios públicos de emergencias, Servicio de Salud, Municipio, etc.</i>	<i>Sistema de telefonía interna lo pueden operar todos los funcionarios que realizan sus funciones en box de CESFAM y SUR. Sistema de telefonía externa fija personal de SOME, Celulares: Según distribución institucional de éstos.</i>
Altoparlantes:	<i>El establecimiento cuenta con un sistema de altoparlantes, los cuales se encuentran en pasillos internos y salas de espera de CESFAM.</i>	<i>Dirección activa número 8030 o 8032 podrá indicar evacuación.</i>
Radiocomunicación:	<i>El establecimiento cuenta con un sistema de radiocomunicación con señal VHF</i>	<i>VHF comunicación directa ambulancias y SUR Peralillo con SAMU HSC, bomberos y seguridad ciudadana municipal.</i>

Esquema de flujos de comunicación o Cadena de llamadas:



b. Información a la Comunidad y Medios de Comunicación

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
Rol a desempeñar por Jefe de Departamento de Salud:		
Tipo	Tiempo	Descripción
Reporte o Informe	1 hora (de transcurrido el evento o incidente)	Informe o reporte preliminar que entrega información (al menos) del tipo de evento o incidente.
Reporte o Informe	A partir de 2 hora posterior al primer reporte preliminar	Informe más detallado respecto del estado de usuarios (que se encuentran o encontraban en el establecimiento) e información a la comunidad respecto del estado del establecimiento. Indicar cómo se establecerá la entrega de información y la temporalidad. Información relevante para entregar: - Nivel de afectación, - Situación de usuarios (de encontrarse al momento del evento en el establecimiento) - Estado del establecimiento (estado de funcionamiento e infraestructura, entre otra que se considere) - Las líneas de acción adoptadas en la respuesta, especialmente la entrega de información a la comunidad cuando corresponda dentro de las líneas de acción. - Deberá indicar próximas vocerías. - Otra información que se estimen necesaria entregar respecto del evento.
Comunicado de Prensa	1 vez al día	Comunicado de prensa que entrega información preliminar de daño a la infraestructura, estado de usuarios y comunidad afectada si corresponde. Lo entrega la Jefa de Departamento de Salud o su subrogante.

11. Activación del plan

ACTIVACIÓN DEL PLAN

De acuerdo con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), la respuesta ante situaciones de Emergencias y Desastres del Sector Salud se desarrollará siguiendo los principios de ayuda mutua y uso escalonado de recursos.

Los eventos, siempre y cuando existan recursos para ello, deben ser manejados localmente, partiendo desde los propios establecimientos, siguiendo luego, Servicio de Salud y Municipio, SEREMI de Salud y, finalmente, el nivel central, tomando en consideración no solo su nivel de afectación, sino que también las características del evento, su extensión y cobertura, riesgo para la salud de la población y otras variables.

Los niveles superiores se irán activando a medida que se vea superada la capacidad local para llevar a cabo las acciones de respuesta, o cuando se requiere el apoyo técnico de los referentes correspondientes en el nivel superior.

El criterio respecto a la superación de la capacidad de respuesta local se establece de acuerdo con los niveles definidos en la Ley 21.364 que establece el SINAPRED. En general, un organismo define la activación del plan de emergencia, a partir del Nivel II.

Hay que considerar que la activación del plan está asociada al nivel de afectación de la continuidad operacional y de atención, especialmente en los equipos de salud, sectores clínicos y de apoyo esenciales para el funcionamiento del establecimiento.

Definición de niveles en la Ley 21.364 (SINAPRED):

- i. Emergencia Menor: situación con un nivel de afectación que permite ser gestionada con capacidades comunales y, eventualmente, con refuerzos o apoyos desde otras zonas, a través de una coordinación de nivel comunal.
- ii. Emergencia Mayor: situación con un nivel de afectación que permite ser gestionada con capacidades regionales y, eventualmente, con refuerzos o apoyos desde otras zonas, a través de una coordinación de nivel provincial o regional.
- iii. Desastre: situación con un nivel de afectación e impacto que no permite ser gestionada con capacidades regionales, y requiere refuerzos o apoyos desde otras zonas del país, a través de una coordinación de nivel nacional.
- iv. Catástrofe: situación con un nivel de afectación e impacto que requiere de asistencia internacional, como apoyo a las capacidades del país, a través de una coordinación de nivel nacional.

Para el caso de Sector Salud, y entendiendo que para efectos de la presente guía la unidad mínima es el establecimiento (CESFAM), los niveles de la emergencia se homologan de acuerdo con los siguientes niveles:

Nivel	Se activa Plan de Emergencia SI/NO	Descripción	Clasificación
Nivel I	NO	En el caso del establecimiento: Situación atendida con recursos locales del establecimiento, habitualmente disponibles: Incendios forestales de menor magnitud, hasta 2 familias allegados, sismo de menor	Emergencia menor

		intensidad (Menores a grado VII escala Mercalli). (Emergencia Menor: situación con un nivel de afectación que permite ser gestionada con capacidades comunales y, eventualmente, con refuerzos o apoyos desde otras zonas, a través de una coordinación de nivel comunal.)	
Nivel II	SI	En el caso del establecimiento: Situación que es atendida con recursos adicionales al establecimiento, por ejemplo, del Municipio, Servicio de Salud, SEREMI de Salud, entre otros: Terremotos, incendios forestales de gran magnitud, calor extremos superior a 3 días, incendios al interior de establecimiento. (Emergencia Mayor: situación con un nivel de afectación que permite ser gestionada con capacidades regionales y, eventualmente, con refuerzos o apoyos desde otras zonas, a través de una coordinación de nivel provincial o regional.)	Emergencia Mayor
Nivel III	SI	En el caso del establecimiento: Situación que es atendida con recursos externos al establecimiento y que requiere recursos de asistencia de Nivel Nacional, por ejemplo, de otras regiones de la afectada. Incendios forestales de mayor magnitud, Mayor a 2 familias allegados, sismo de mayor intensidad (Superior a grado VII escala Mercalli). (Desastre: situación con un nivel de afectación e impacto que no permite ser gestionada con capacidades regionales, y requiere refuerzos o apoyos desde otras zonas del país, a través de una coordinación de nivel nacional.)	Desastre
Nivel IV	SI	Situación que requiere recursos de asistencia de nivel Internacional (Catástrofe: situación con un nivel de afectación e impacto que requiere de asistencia internacional, como apoyo a las capacidades del país, a través de una coordinación de nivel nacional.)	Catástrofe

12. Evaluación de Daños y Necesidades

REPORTE GENERAL DE EMERGENCIAS Y EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES (EDAN)		
El detalle del instrumento para el reporte general de emergencias y evaluación de daños y el análisis de necesidades se encuentran en el Anexo 8.4 y 8.5.		
Nombre de reporte / Informe	Reportado por:	Distribuido a:
Reporte General de Emergencias	Coordinador/a de Emergencias y Desastres Servicio de Salud (o SEREMI de salud en su defecto) Coordinado con Coordinador/a Emergencias del Establecimiento.	Sr. Alcalde, Servicio de Salud, con copia a instancias superiores como la coordinación de emergencia de SEREMI de Salud de la Región.
Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN y EDAN Salud Mental)	Referente administrativo SUR y Referente Salud Mental	Sr. Alcalde, Servicio de Salud, con copia a instancias superiores como la coordinación de emergencia de SEREMI de Salud de la Región.

13. Implementación, revisión periódica y Readecuación del Plan

IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN PERIÓDICA, ACTUALIZACIÓN Y READECCUACIÓN DEL PLAN
IMPLEMENTACIÓN: Difusión: El Plan de Emergencias del Establecimiento, aprobado por el director/a de este, quien lo enviará a todas las áreas del establecimiento, así como al director/a del Servicio de Salud correspondiente, director/a de Salud Local y Coordinador/a de Emergencia Municipal. Será responsabilidad del director/a del establecimiento y de las jefaturas de este, el conocer las disposiciones contenidas en el plan, así como darlas a conocer a todo el personal. Debe estar accesible y de conocimiento de todos los funcionarios. El plan de emergencia del establecimiento se encontrará disponible en formato digital vía mail y biblioteca de calidad. Capacitación: Las acciones de capacitación e inducción que se realicen, orientadas a las/os funcionarias/os del establecimiento en temas de emergencias y desastres, deben contener las disposiciones sobre organización y funcionamiento de las distintas áreas mencionadas en el plan, con énfasis en los roles y funciones de los actores relacionados con la respuesta a situaciones de emergencias, desastres y epidemias. Todo el personal del establecimiento deberá conocer el plan de emergencias. REVISIÓN PERIÓDICA: Revisión Interna: Toda propuesta de modificación del plan de emergencias debe ser analizada por el COGRID y aquellos actores relevantes si no están incluidos. Cumplido lo anterior, la propuesta de

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 32 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

modificación será presentada al director/a del establecimiento, para su aprobación y pasar a ser parte del texto del Plan.

Igualmente, cuando hay modificaciones de las capacidades y recursos del establecimiento y cuando se identifique nuevos riesgos o amenazas para las personas, el plan deberá ajustarse a las nuevas condiciones por ejemplo de reconversión de espacios, nuevas vías de evacuación, zonas seguras, funcionarios temporales o de dispositivos anexos implementados.

Evaluación: la evaluación del plan se llevará a cabo a través de la realización de simulaciones o simulacros de distinto alcance, los que deberán realizarse al menos una vez al año bajo la responsabilidad del/la director/a y encargado/a o coordinador/a de emergencias y desastres del establecimiento. Se podrá idealmente, solicitar apoyo para la realización y evaluación de estos ejercicios a entidades del sector como el Servicio de Salud, Municipio y/u otras entidades como Bomberos, Carabineros, etc.

De igual forma la atención a eventos reales podrá brindar información para modificar aquellas secciones en que se hayan identificado oportunidades de mejora.

Al diseñar una simulación o simulacro, los responsables se deben guiar por los siguientes principios:

1. Debe responder a los propósitos establecidos en el Plan de Emergencia.
2. Debe ser ejecutable por medio de técnicas conocidas, personal entrenado y equipado.
3. No poner en riesgo a la comunidad y los grupos de respuesta que intervienen en él.
4. Debe ser realizado en circunstancias lo más cercano a la realidad.
5. Observar el debido control y ejercicio de las variables en el simulacro, a fin de no perturbar las actividades normales del establecimiento y de la comunidad circundante.
6. Considerar finalizar el simulacro en caso de un evento real que se produzca durante su realización.
7. Registro y evaluación del ejercicio. Registrar fecha de realización, participantes en la respuesta, participantes en la evaluación, tiempos de realización. Igualmente identificar brechas y mejoras necesarias para el plan.
8. Indicar el momento en que finaliza el ejercicio.

Se recomienda la utilización de la Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros de emergencias y desastres, de la Organización Panamericana de la Salud, año 2010, indicada en Documentos de referencia Anexo 8.2.

ACTUALIZACIÓN

Las actualizaciones se harán según circunstancias o hechos especiales que lo hagan necesario. Sin embargo, se recomienda que la actualización del Plan sea al menos 1 vez al año. Aprobada una actualización según lo señalado en el procedimiento mencionado en “Revisión interna”, la referencia al texto actual deberá quedar consignada como antecedente en el cuadro que figura en Anexo 8.1.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 33 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

14. Anexos

a. Cuadro de Control de Actualizaciones

CUADRO DE CONTROL DE ACTUALIZACIONES							
N°	Fecha	N° Índice	Página (s)	Descripción del Cambio	N° Res. Ex.	Elaborado por	Autorizado por
1	3-1-23		6	Cambio N° total funcionarios	NA	NA	NA
2	3-1-23/9-1-24		11	Cambio N° percapitados	NA	NA	NA
3	3-1-23		12	Se elimina individualización de trabajadores con discapacidad	NA	NA	NA
4	3-1-23		13	Se actualiza con 2 autoclaves operativos	NA	NA	NA
5	3-1-23		16	Se actualiza con red húmeda operativa	NA	NA	NA
6	3-1-23		40	Se actualiza matriz de riesgo	NA	NA	NA
7	3-1-23		56	Se actualiza ficha de enlace intra y extra sectorial	NA	NA	NA
8	7-1-24		11	Cambio N° percapitados	NA	NA	NA
9	7-1-24		16	Se actualiza con red de agua potable autónoma.	NA	NA	NA

b. Marco Legal y Normativo

Sin que la enumeración sea taxativa a continuación se lista el marco legal y normativo, resoluciones y circulares asociadas, así como documentos de referencia.

Número	Fecha	Título	Facultad Asignada
DFL 725	1967	Código Sanitario	Art. 36, Permite otorgar facultades extraordinarias a la Autoridad de Salud cuando una parte del territorio se viere amenazada o invadida por una epidemia o por un aumento notable de alguna enfermedad, o cuando se produjeran emergencias que signifiquen grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes, en cuyo caso podrá el Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia. Art. 178, En casos de riesgo inminente para la salud de la población, la SEREMI de Salud podrá imponer medidas sanitarias, tales como: prohibición de funcionamiento, clausura, decomiso, entre otras.
DS 594	1999	Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales Básicas En Los Lugares De Trabajo	Art. 3, La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean terceros contratistas que realizan actividades para ella. Art. 37, Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectarla salud o integridad física de los trabajadores.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 34 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

			Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además deberán cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Art. 42, El empleador mantendrá disponible permanentemente en el recinto de trabajo, un plan detallado de acción para enfrentar emergencias, y una hoja de seguridad donde se incluyan, al menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: nombre comercial, fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, características físico químicas, tipo de riesgo más probable ante una emergencia, croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen las vías de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar emergencias. Respecto del almacenamiento de sustancias peligrosas este se regirá por lo dispuesto en el D.S. N° 78/2010 del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, para aquellas exclusiones establecidas en el artículo 3 de dicha norma, los recintos que almacenen sustancias peligrosas clasificadas según NCh 382/2013, sin perjuicio de la normativa específica que les aplique, deberán disponer de un plan de emergencias que incorpore todas las posibles emergencias que puedan producirse, con sus respectivos procedimientos, cadena de mando, plano que incluya todas las instalaciones, zonas de seguridad, vías de acceso y de salida, lista actualizada de sustancias peligrosas, equipos y elementos para combatir la emergencia. Art. 44. En todos los lugares de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido.
DS 735	1969	Reglamento de los Servicios de Agua para Consumo Humano	Art. 21. Deberán también consultarse las instalaciones de reservas necesarias para que al quedar fuera de servicio cualquier parte del sistema, no perjudique el abastecimiento de la población.
DS 6	2009	Reglamento Sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS)	Art. 41.- Los establecimientos que deben presentar plan de manejo, así como las empresas de transporte y las instalaciones de eliminación de REAS, deberán contar con un plan de contingencias, en el que se describirán todas las medidas a desarrollar frente a eventuales emergencias. Este plan deberá contemplar al menos lo siguiente: 1.- Medidas de control o mitigación. 2.- Capacitación del personal que maneja residuos. 3.- Identificación de las responsabilidades del personal. 4.- Sistema de comunicaciones, fijo o portátil, para alertar a las autoridades competentes. 5.- Identificación, ubicación y disponibilidad de personal y equipo necesario para atender las emergencias. 6.- Listado actualizado de los organismos públicos y personas a las que se deberá dar aviso inmediato en el caso de ocurrir una emergencia. Considerar, al menos, la comunicación con la autoridad sanitaria, Carabineros, Bomberos y la Oficina Regional de Emergencia cuando la emergencia sea de magnitud tal que pueda afectar la salud y/o seguridad de las personas o del ambiente.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO		Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL		Página 35 de 67
	Fecha: 06-01-2026		

DS 148	2004	Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos	Art. 3. Para los efectos del presente reglamento, las expresiones que aquí se indican tendrán el significado que se señala: Generador: titular de toda instalación o actividad que dé origen a residuos peligrosos. Hoja de Seguridad para el Transporte de Residuos Peligrosos: documento para transferir información sobre las características esenciales y grados de riesgo que presentan los residuos peligrosos para las personas y el medio ambiente, incluyendo aspectos de transporte, manipulación, almacenamiento y acción ante emergencias desde que una carga de residuos peligrosos es entregada por el generador a un medio de transporte hasta que es recibido por el destinatario. Artículo 6 Durante el manejo de los residuos peligrosos se deberán tomar todas las precauciones necesarias para prevenir su inflamación o reacción, entre ellas su separación y protección frente a cualquier fuente de riesgo capaz de provocar tales efectos. Además, durante las diferentes etapas del manejo de tales residuos, se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente.
DFL 1	2005	Ley Orgánica Ministerio de Salud	Art. 4 N°3, A las Seremis corresponde la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, laboratorios y farmacias. Art. 4 N°10, Al Ministerio de Salud le corresponde velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles. Art. 70 c), Serán funciones de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud atender las necesidades que en las materias de su competencia le encomiende satisfacer el Supremo Gobierno, en caso de emergencias nacionales o internacionales.
D.S. 136	2004	Reglamento Orgánico Ministerio de Salud	Art. 9, Declarar emergencia y disponer alerta sanitaria.
D.S. 140	2004	Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud	Art21., El Departamento Subdirección de Gestión Asistencial dependerá del Director de Servicio, y tendrá las siguientes funciones: Desarrollar procesos de planificación permanente de la Red Asistencial en, a lo menos, las áreas de articulación de la Red Asistencial, gestión clínica, gestión de cuidados, inversiones, presupuesto, participación social y atención al usuario, comunicaciones, emergencias y catástrofes...”
Decreto 58	2008	Aprueba Normas Técnicas Básicas para la obtención de Autorización Sanitaria de los Establecimientos Asistenciales	Anexo 2. En general Ámbito Organización, Infraestructura, específicamente aquellos relacionados con condiciones de accesibilidad y seguridad general, entre otras.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO		Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL		Página 36 de 67
	Fecha: 06-01-2026		

DFL 1	2006	Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades	Funciones y atribuciones (i) La Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio de la comuna, la que comprenderá especialmente las acciones relativas a las Fases de Mitigación y Preparación de estos eventos, así como las acciones vinculadas a las Fases de Respuesta y Recuperación frente a emergencias.
Ley 19378	1995	Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal	Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud.
Decreto 1434	2017	Aprueba Plan Nacional de Emergencia	3. Levantamiento de Capacidades; 3.1. Roles, Funciones y Capacidades de Organismos Pertenecientes al Sistema Nacional de Protección Civil: Ministerio de Salud f) Elaborar y ejecutar protocolos y Planes de Emergencias y Desastres en todos los Servicios de Salud y Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, así como en los establecimientos de la red.
Ley 21364	2021	Establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa normas que indica	Art. 1. Créase el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en adelante “el Sistema”, conformado por el conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas con las fases del ciclo del riesgo de desastres, que se organizan desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional, para garantizar una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres, y comprende las normas, políticas, planes y otros instrumentos y procedimientos atinentes a la Gestión del Riesgo de Desastres.
Decreto 47	1992	Fija Nuevo Texto De La Ordenanza General De La Ley General De Urbanismo Y Construcciones	Título 4 De La Arquitectura Capítulo 1. De las Condiciones de Habitabilidad Capítulo 2. De las condiciones Generales de Seguridad Capítulo 3. De las Condiciones de Seguridad Contra Incendio Capítulo 4. Edificios de Asistencia Hospitalaria.
Decreto 76	2007	Aprueba Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica.	“...Asimismo, deberá confeccionarse un plan o programa de trabajo de las actividades en materia de seguridad y salud laboral, que contenga las medidas de prevención establecidas, los plazos en que estas se ejecutarán y sus responsables, las acciones de información y formación, los procedimientos de control de los riesgos, planes de emergencia, la investigación de accidentes.”
D.S. 230	2005	Reglamento Sanitario Internacional	Instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que prescribe medidas a los Estados para prevenir la propagación transfronteriza de enfermedades infecciosas, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada a los riegos, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio. Incluye, además, medidas de aplicación ordinaria en los puertos y aeropuertos para conseguir la máxima seguridad contra la propagación internacional de enfermedades, con un mínimo de trabas para el tráfico mundial.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 37 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

Resoluciones y Circulares asociadas

1. **Resolución Exenta Nº185, de 16 de febrero de 2018**, Aprueba Plan de Emergencia Sectorial del Sector Salud.
2. **Resolución Exenta Nº157, de 7/marzo/2008**. Crea Oficina de Reglamento Sanitario Internacional en el Ministerio de Salud.
3. **Circular Nº4, del 5/marzo/2010**. Establece Normas de Control de infecciones asociadas a la atención en salud durante emergencias y desastres.
4. **Circular Nº7, de 2/mayo/2011**. Establece normas para la prevención de infecciones asociadas a modificaciones estructurales y otras actividades que generan polvo ambiental en establecimientos hospitalarios.
5. **Circular C13 Nº9, de 13/marzo/2013**. Establece precauciones estándares para el control de infecciones en la atención en salud y algunas consideraciones sobre el aislamiento de pacientes.
6. **Circular Nº18, de 21/septiembre/2018**. Instruye sobre Procedimientos para el Reporte de Eventos y la Gestión de Información en Situaciones de Emergencias y Desastres por los Servicios de Salud y SEREMIS de Salud.
7. **Decreto Exento 0211 mayo 2021**. Aprueba las normas y orientaciones técnicas, de Postas de Salud Rural.

Documentos de referencia

1. **Ordinario A23/ Nº245, de 17 de enero de 2019**, Envía formato Plan de Respuesta del Sector Salud (SEREMI y Servicios de Salud)
2. **Ordinario C37/ Nº1556, de 10 de abril de 2019**, Guía de Preparación Documental y Antecedentes para solicitar Autorización Sanitaria para Establecimientos de Salud Atención Abierta.
3. **NCh 3359 2015, Requisitos para Edificaciones Estratégicas de Servicio Comunitario**.
4. **Ordinario C37/ Nº1976, de 30 de junio de 2020**, Aplicación de lista de chequeo de mantención preventiva a equipos médicos críticos, respecto de los cuales, no se han realizado su mantención preventiva de acuerdo con su planificación anual y local.
5. **Ordinario C4/Nº1061, de 7 de marzo de 2019**, Directrices Técnicas para el Mantenimiento Preventivo de Equipos Críticos en el marco del Proceso de Acreditación de Calidad de Prestadores de Salud de Atención Abierta.
6. **Establecimientos de Salud Resilientes al Clima y Ambientalmente Sostenibles, Orientaciones de la OMS. Organización Mundial de la Salud 2021.**
<https://www.paho.org/es/documentos/establecimientos-salud-resilientes-al-clima-ambientalmente-sostenibles-orientaciones-oms>
7. **Guía de Evaluadores Índice de Seguridad Hospitalaria**, Organización Panamericana de la Salud, segunda edición, 2018.
8. **Inclusión para la gestión del riesgo de desastres en hospitales**, Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C.: OPS; 2018. <https://www.paho.org/disasters/dmdocuments/Ingridh-Spa.pdf>
9. **Herramienta para Hospitales Inteligentes**. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C.: OPS; 2018.
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:smart-hospitals-toolkit&Itemid=1248&lang=es
10. **Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres**. UNISDR, 2016.
11. **Guía para la reducción de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud**, Centro Colaborador OPS/OMS de Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud Universidad de Chile, Rubén Boroschek Krauskopf y Rodrigo Retamales Saavedra, 2004.
12. **Hospitales seguros ante inundaciones**, Organización Panamericana de la Salud, 2006.
13. **Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud**, Organización Panamericana de la Salud, 2004
14. **Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros de emergencias y desastres**, Organización Panamericana de la Salud, 2010

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 38 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

15. **Guía para el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional.** OPS/OMS. 2005.

16. **Guía de Vigilancia Epidemiológica en Emergencias y Desastres. Departamento de Epidemiología. División de Planificación Sanitaria.** Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud. 2010.

17. **Medidas Generales de Salud Ambiental en Emergencias y Desastres. Departamento de Salud Ambiental. División de Políticas Públicas Saludables y Promoción.** Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud. 2010.

18. **Recomendaciones para prevenir enfermedades, frente al impacto de un terremoto y tsunami. División de Políticas Públicas Saludables y Promoción.** Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud. 2010.

19. **Guía de Emergencias y Desastres en los Ámbitos de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción.** Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud. 2011.

20. **Guía para la Elaboración de Planes Hospitalarios de respuesta ante Emergencias y Desastres.** Departamento de Emergencias y Desastres. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud. febrero 2020.

21. **Guía de radiocomunicaciones en emergencias.** Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres. Ministerio de Salud. 2012.

22. **Modelo de Protección de la Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Desastres.** MINSAL, ONEMI, CIGIDEN, JICA, 2018.

23. **Manual de Procedimientos: Medidas de Salud Ambiental frente a Erupciones Volcánicas, Erupciones volcanes Chaitén (2008) y Puyehue-Cordón Caulle (2011).** Departamento de Salud Ambiental. División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. Subsecretaría de Salud Pública. Ministerio de Salud. 2012.

24. **Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud.** Ministerio de Salud. 2016.

25. **Ordinario N°245/2019.Formato para elaboración de Planes de Emergencias Seremis y Servicios de Salud.** Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres, Gabinete de Ministro, Ministerio de Salud. 2019.

26. **Orientaciones Técnicas Establecimientos de Salud Seguros frente a desastres,** Resolución exenta 2048 de 2019.

27. **Ordinario N°4830 de 2019** de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que remite el **Modelo de gestión para el mantenimiento de equipos Médicos e Infraestructura de Establecimientos de Atención primaria (APS)**

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 39 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

c. Matriz de Riesgo o de Amenazas del establecimiento.

8.3.1. Inicialmente es necesario indicar que la formulación de los Planes de Emergencias y Desastres Regionales elaborados por la Coordinación de Emergencias de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud contempla la elaboración una Matriz de Riesgos cuyo objetivo es identificar, describir y priorizar los riesgos asociados a las diferentes amenazas reconocidas en las diferentes zonas y regiones, teniendo en consideración el rol que compete a SEREMIS y Servicios de Salud locales. Para los efectos de la elaboración de esta Matriz, el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y las consecuencias negativas que éste pueda desencadenar en la salud y seguridad de las personas y la población.

La matriz de riesgo permite, previo a la construcción o actualización del cada Plan Regional de Emergencia, tener a la vista, de manera fundamentada, las principales amenazas naturales y antrópicas presentes en el territorio, siguiendo la recomendación de OPS/OMS en cuanto a que “para planificar las acciones de preparación del sector salud para situaciones de desastres es fundamental primeramente conocer las principales amenazas y su posible impacto en la localidad, el avance del sector salud en las acciones de preparación frente a desastres, las instituciones del sector salud y sus principales recursos” (OPS, 2003).

La metodología utilizada para la elaboración de las Matrices de Riesgo ha sido modificada para incorporar explícitamente, junto al resto de las amenazas históricamente evaluadas, la consideración de las amenazas asociadas al cambio climático identificadas en cada territorio.

8.3.2. El Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) expresa la probabilidad de que un hospital continúe funcionando en casos de desastre.⁶ Se obtiene mediante el uso de una lista de verificación que contiene una serie de aspectos o variables de evaluación, aplicando estándares de seguridad y asignándole pesos relativos a cada aspecto evaluado. **Se estima que es de utilidad para establecimientos de atención primaria como una herramienta de referencia para poder por una parte ponderar las amenazas que pueden afectar al establecimiento y/o a la población usuaria de este, priorizando aquellos planes por variable de riesgo que deben ser abordados,** y por otra analizar la vulnerabilidad del establecimiento, reconociendo brechas tanto en los aspectos estructurales, no estructurales y de gestión de riesgo de emergencias y desastres. Por ello se considera que esta herramienta puede orientar a los comités de emergencia y autoridades en cuanto a los riesgos y amenazas presentes en el establecimiento y que pueden afectar a la población que atiende, generando además planes de mejora para aumentar el nivel de seguridad del establecimiento.

A continuación, se presenta el módulo 1 del formulario de evaluación del ISH, correspondiente a la evaluación de amenazas que puedan afectar la seguridad del establecimiento, la función de este en la gestión de emergencias y desastres, y la población usuaria.

El análisis de la ubicación geográfica del establecimiento “permite evaluar las amenazas en relación con emergencias y desastres anteriores en la zona, y determinar el tipo de amenazas que pueden afectar al establecimiento de acuerdo con el tipo de terreno donde fue construido. También se debe hacer hincapié en las amenazas internas, como los incendios, las fallas de las líneas vitales (por ejemplo, agua, electricidad) y las amenazas contra la vigilancia y protección del edificio, los pacientes, los visitantes y el personal...”⁷

Este Instrumento publicado en su segunda edición en el año 2018, incorpora las amenazas relacionadas con el cambio climático, a saber, meteorológicas, hidrológicas y climáticas, entre otras; amenazas que generan eventos cada día más frecuentes, con mayor intensidad y que presentan cambios de estacionalidad.

⁶ Organización Panamericana de la Salud, Índice de Seguridad Hospitalaria, Guía del Evaluador, primera edición, pág. 15
⁷ Organización Panamericana de la Salud, Índice de Seguridad Hospitalaria, Guía de Evaluadores, segunda edición, Washington, D.C., 2018, pág. 38.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 40 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

Es importante considerar que existen herramientas para análisis de diversas amenazas (por ejemplo, Módulo de Emergencias de la Plataforma MIDAS⁸, Mapa de Amenazas o Riesgos que disponga el Municipio, Visor ONEMI⁹, Dirección Meteorológica de Chile¹⁰, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada SHOA¹¹, Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN¹², Infraestructura de Datos Geoespaciales IDE Chile, del Ministerio de Bienes Nacionales¹³, entre otras), registros históricos y consultar con el personal del establecimiento respecto de eventos ocurridos con anterioridad, apoyándose en la mejor información que pueda obtenerse para estimar el nivel de la amenaza.

Amenazas que afectan a la seguridad del establecimiento y la función de este en la gestión de emergencias y desastres, aplicables a la atención primaria.

Este instrumento debe ser completado por el COGRID.

La exposición se mide (o se estima) combinando la probabilidad de que una amenaza se materialice y la magnitud de ésta. De esta manera, las amenazas se pueden clasificar como altas (si es grande la probabilidad de que ocurran o son de gran magnitud), medias (una probabilidad elevada de amenazas moderadas) y bajas (poca probabilidad o amenazas de poca magnitud)¹⁴.

1.1 Amenazas	Nivel de la amenaza				¿Debe prepararse el establecimiento para responder a esta amenaza? Si es afirmativo, marque el recuadro	Observaciones (comentarios de los evaluadores)
	Nulo	Bajo	Medio	Alto		
Amenazas naturales						
1.1.1 Amenazas geológicas						
Terremotos Basándose en los mapas de amenazas regionales y locales u otra información sobre el particular, clasifique el nivel de amenaza sísmica para la ubicación del establecimiento (incluida la zona de influencia) en función de los análisis geotécnicos del suelo. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por terremotos (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de heridos).				X	X	Simulación y/o simulacros en caso de sismos.
Actividad volcánica y erupciones Consulte los mapas de amenazas regionales y locales u otra información sobre el particular y clasifique el nivel de las amenazas volcánicas para la ubicación del establecimiento. Tenga en cuenta la proximidad de volcanes, la actividad volcánica, las rutas del flujo de lava, el flujo piroclástico y la lluvia de ceniza. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por actividad volcánica o erupción (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento).		X				

⁸ MIDAS, Modernización de la Información de la Autoridad Sanitaria. En esta Plataforma se encuentra el Módulo de reportería de emergencias del sector salud. Mayor descripción en Anexo 8.14. Glosario.

⁹ <https://www.onemi.gov.cl/visor-chile-preparado/> igualmente pueden consultar a través del Municipio/Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres el Visor ONEMI

¹⁰ <http://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC-web/index.xhtml>

¹¹ <http://www.shoa.cl/php/index.php>

¹² <https://sernageomin.cl>

¹³ <http://www.geoport.cl/visorgeoport/>

¹⁴ Organización Panamericana de la Salud, Índice de Seguridad Hospitalaria, Guía de Evaluadores, segunda edición, Washington, D.C., 2018, pág. 39.

Desplazamientos de masas secas: deslizamientos de tierra Consulte los mapas de amenazas regionales y locales u otra información sobre el particular y clasifique el nivel de la amenaza de deslizamientos de tierra para el lugar del establecimiento. Tenga presente que estos desplazamientos pueden ser causados por suelos inestables. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por deslizamientos de tierra (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).			X		X	Sector Rinconada de Molineros.
Tsunamis Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular y clasifique el nivel de la amenaza para la ubicación del establecimiento por tsunamis causados por la actividad sísmica o volcánica submarina. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por tsunamis (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia.)	X					
Otras amenazas geológicas (por ejemplo, aludes de rocas, hundimientos, y deslizamiento de detritos o fangos) (Sírvase especificar) Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular para identificar otros fenómenos geológicos. Especifique la amenaza y califique el nivel correspondiente para el establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por las amenazas geológicas identificadas (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).		X				
1.1.2 Amenazas hidrometeorológicas						
1.1.2.1 Amenazas meteorológicas						
Huracanes, ciclones y tifones Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular y clasifique el nivel de las amenazas para la ubicación del establecimiento planteadas por huracanes, ciclones o tifones. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por huracanes, ciclones o tifones (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).		X				
Tornados Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular y clasifique el nivel de la amenaza por tornado para la ubicación del establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por tornados (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).		X				
Tormentas Clasifique el nivel de la amenaza para el establecimiento en relación con inundaciones u otros daños causados por lluvias intensas (o torrenciales) relacionadas con tormentas, basándose en los antecedentes locales de tales eventos. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por tormentas (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).				X	X	Recambio de techo CESFAM con canaletas y bajadas de agua

Temperaturas extremas (por ejemplo, olas de calor, olas de frío, inviernos extremos o dzuds) Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular y clasifique el peligro de las amenazas debidas a condiciones extremas de temperatura o climáticas. Especifique la amenaza y califique el nivel correspondiente para la ubicación del establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por temperaturas extremas (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).				X	X	Olas de Calor
Incendios forestales (por ejemplo, en bosques, tierras cultivadas o zonas habitadas) Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular y clasifique el nivel de la amenaza de incendios forestales para la ubicación del establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por incendios forestales (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento)				X	X	Información de prevención de incendios al CDLS
Sequías Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular y clasifique el nivel de la amenaza de sequías para la ubicación del establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por una sequía (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de la desnutrición).				X	X	
Otras amenazas climáticas, incluidas las atribuibles al cambio climático (por ejemplo, aumento del nivel del mar) (Sírvase especificar) Clasifique el nivel de la amenaza para el establecimiento con relación al riesgo de otras amenazas climáticas, basándose en los antecedentes de dichos eventos y la modelización de amenazas. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por otras amenazas climáticas (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).	X					
1.1.3 Amenazas biológicas						
Epidemias, pandemias y enfermedades emergentes Teniendo en cuenta cualquier evaluación de riesgos, incidentes anteriores en el establecimiento y agentes patógenos específicos, clasifique el nivel de la amenaza para el establecimiento de epidemias, pandemias y enfermedades emergentes. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por epidemias, pandemias y enfermedades emergentes (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de enfermedades infecciosas).				X	X	Plan de trabajo para contención pandemia
Brotes de intoxicación alimentaria Con relación a cualquier evaluación de riesgos e incidentes anteriores en el sitio del establecimiento (en particular la zona atendida), clasifique el nivel de la amenaza de brotes de intoxicación alimentaria. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).				X	X	Arsenal asegurado en SUR

Plagas (por ejemplo, infestaciones) Tomando como referencia cualquier evaluación de riesgos e incidentes anteriores en el establecimiento, clasifique el riesgo para el establecimiento de la exposición a amenazas por plagas o infestaciones (moscas, pulgas, roedores, etcétera). Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por plagas o infestaciones (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).					X	X	Control de plagas por empresa externa 3 veces al año
Otras amenazas biológicas (Sírvese especificar) Teniendo en cuenta cualquier evaluación de riesgos, clasifique el nivel de la amenaza para el establecimiento en relación con otras amenazas biológicas. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por otras amenazas biológicas (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de pacientes expuestos a amenazas biológicas).							
Amenazas causadas por el ser humano							
1.1.4 Amenazas tecnológicas							
Amenazas industriales (por ejemplo, químicas, radiológicas) Consulte los mapas regionales y locales de los establecimientos industriales u otra información sobre el particular y cualquier incidente anterior que haya implicado amenazas industriales y clasifique el nivel de éstas para la ubicación del establecimiento y la posible contaminación de los sistemas establecimiento arios. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por amenazas industriales (basándose en la exposición de la población de la zona atendida o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de pacientes expuestos a amenazas industriales).							
					X		
Incendios (por ejemplo, de edificios) Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre incendios de edificios dentro y fuera del establecimiento, así como cualquier incidente anterior relacionado con incendios de edificios, y clasifique el nivel de la amenaza de incendio para el establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por incendios de edificios (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de pacientes quemados).							
					X	X	Plan de evacuación.
Materiales peligrosos (por ejemplo, químicos, biológicos, radiológicos) Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre materiales peligrosos (incidentes y derrames) dentro y fuera del establecimiento, así como cualquier incidente anterior relacionado con derrames o fugas de materiales peligrosos, y clasifique el nivel de la amenaza por materiales peligrosos para el establecimiento y la posible contaminación de sus sistemas. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o							
Químicos					X	X	Manejo de heridas, intoxicaciones, quemaduras entre otras.
Biológicos					X		
Radiológicos					X		

desastre causado por materiales peligrosos (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de pacientes expuestos a materiales peligrosos).						
Cortes de luz (apagones) Tenga en cuenta los incidentes anteriores relacionados con cortes de luz en la ubicación del establecimiento y clasifique el nivel de esta amenaza para el establecimiento. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por cortes de luz.				X	X	Mantención de generadores, compra de UPS
Interrupción del suministro de agua Tenga en cuenta los incidentes anteriores relacionados con la interrupción del suministro de agua en la ubicación del establecimiento y clasifique el nivel de la amenaza de la interrupción del suministro de agua para el establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por la interrupción del suministro de agua.			X		X	Acondicionar reservas de agua
Incidentes de transporte (por ejemplo, aéreo, terrestre, ferroviario o acuático) Tenga en cuenta los registros de incidentes de transporte mayores en el pasado y determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por incidentes de transporte (basándose en la exposición de la población de la zona atendida).				X	X	Múltiples accidentes en ruta I90
Otras amenazas tecnológicas (por ejemplo, contaminación atmosférica, colapsos estructurales, contaminación de los alimentos o el agua, escape nuclear) (Sírvese especificar) Consulte los mapas de amenazas regionales o locales u otra información sobre el particular y acerca de incidentes anteriores, y clasifique el nivel de las amenazas tecnológicas para el establecimiento. Especifique el peligro y califique el nivel de la amenaza correspondiente para la ubicación del establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por otras amenazas tecnológicas (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de pacientes expuestos a otras amenazas tecnológicas).		X				Desechos de viñas
1.1.5 Amenazas de índole social						
Amenazas a la seguridad y protección del edificio y del personal del establecimiento Tenga en cuenta las evaluaciones del riesgo o amenazas y los incidentes anteriores que hayan afectado al establecimiento y su personal, y clasifique el nivel de las amenazas a la seguridad y protección del establecimiento y su personal. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastres a causa de amenazas a la seguridad y protección del edificio y del personal del establecimiento.				X	X	Mantenciones según necesidad. Amenazas psicológicas al personal
Conflictos armados Tenga en cuenta las evaluaciones del riesgo de conflictos armados e incidentes anteriores que hayan afectado al establecimiento y clasifique el nivel de la amenaza de los conflictos armados. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por conflictos armados (basándose			X		X	Mantenciones según necesidad.

en la exposición de la población de la zona de influencia).						
Disturbios (incluidas manifestaciones) Tenga en cuenta las evaluaciones del riesgo de agitación social e incidentes anteriores que hayan afectado al establecimiento y clasifique el nivel de la amenaza para el establecimiento en relación con manifestaciones y disturbios. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por manifestaciones y disturbios (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).		X				
Reuniones multitudinarias Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por reuniones multitudinarias (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia).			X		X	Fiesta de la vendimia, celebraciones varias.
Poblaciones desplazadas Tenga en cuenta las evaluaciones del riesgo con relación a grupos de población desplazados por causa de conflictos armados, disturbios y otras circunstancias sociopolíticas o por grandes flujos de inmigrantes. Determine si el establecimiento debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre relacionado con poblaciones desplazadas.			X			Migración de población extranjera y nacional.
Otras amenazas sociales (por ejemplo, explosiones, ataques terroristas) (Sírvase especificar) Tenga en cuenta las evaluaciones del riesgo, la información regional y de otro tipo sobre amenazas e incidentes anteriores para determinar otros riesgos de índole social. Especifique la amenaza y califique el nivel correspondiente para la ubicación del establecimiento. Determine si este debería estar preparado para responder a una emergencia o desastre causado por otras amenazas de índole social (basándose en la exposición de la población de la zona de influencia o la función especializada del establecimiento para el tratamiento de pacientes expuestos a amenazas de índole social).	X					
1.2 Propiedades geotécnicas del suelo						
Licuefacción Teniendo en cuenta el análisis geotécnico de suelos en el lugar del establecimiento, clasifique el nivel de la amenaza para el establecimiento relacionada con el subsuelo saturado y suelto.		X				
Suelos arcillosos Consulte los mapas de suelos y otra información sobre amenazas y clasifique el nivel de la amenaza que plantea un suelo arcilloso para el establecimiento.		X				
Pendientes inestables Consulte los mapas geológicos u otra información sobre amenazas y especifique la exposición del establecimiento a las amenazas relacionadas con la presencia de pendientes.		X				
Otras de origen natural (caídas de árboles, ramas de árboles por deterioro natural)			X			

Comentarios respecto de Amenazas que afectan a la seguridad del establecimiento y la función de este en la gestión de emergencias y desastres.

En general el establecimiento se encuentra en buenas condiciones de infraestructura, no se observan grietas en muros ni pisos. Se han mejorado con el tiempo las líneas vitales, sobretudo en el suministro eléctrico tanto en CESFAM como Postas. Es de suma

importancia establecer un sistema de recolección de agua que permita autonomía en este servicio. De la misma forma es importante plantear planes de emergencia que involucren simulacros para todos los funcionarios.

d. **Ficha de Reporte General de Emergencias (Debe realizarlo el Coordinador GRD-Referente técnico SUR).**

	(QTC) REPORTE DE EMERGENCIA:		Nº REPORTE:
	1. NOMBRE EVENTO:		
	2. ELABORADO POR:	3. CARGO / FUNCION:	
4. Minuta generada el DD / MM / AAA a las hh:mm			
5. TIPO DE EVENTO:	6. OCURRENCIA DEL EVENTO: DÍA :DD/ MM / AAA HORA : hh: mm	7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:	
8. DIRECCIÓN/UBICACIÓN:	9. REGIÓN / SERVICIO / COMUNAS AFECTADAS:(QRJ)		
10. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO			
11. IMPACTO EN LAS PERSONAS: 11.1 NUMERO HERIDOS ACUMULADO: 11.2 NUMERO FALLECIDOS:			
12. ESTÁ EN RIESGO LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL:			
13. ¿EN QUÉ HA SIDO SUPERADA SU CAPACIDAD PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y EFECTIVA?			
14. SÍNTESIS DE ESTADO DE SITUACIÓN			
15. SÍNTESIS DE LÍNEAS DE ACCIÓN			
16. SÍNTESIS DE NECESIDADES DEL MOMENTO			
TERMINO DE MENSAJE (QSL)			
QRA Oper. Tx		Cargo o Función	(QTR)
QRA Oper. Rx		Cargo o Función	

Enviar a Coordinador(a) de Servicio de Salud con copia a SEREMI y MINSAL (según medios disponibles en normalidad o interrupción de telecomunicaciones tradicionales)	Incorporar en copia de distribución a Turno Emergencias MINSAL según medios disponibles: 1) https://midas.minsal.cl/ 2) Correo Turno MINSAL devd@minsai.cl 3) Teléfono Móvil Turno MINSAL (+56) 9 89027282 4) Anexo Estación de RA 240722 5) Teléfono Satelital: 881632567646; 6) Red HF MINSAL: (Frec.: 5.420 – 7.660 – 10.450 MHz)
--	--

e. **Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN (Lo debe realizar Referente Administrativo SUR)**

i. **EDAN Establecimientos**

(Ejemplo de EDAN establecimientos disponible en Plataforma MIDAS, módulo Emergencias. Esta Ficha es única tanto para establecimientos hospitalarios como de atención primaria, por tanto, en los campos que no correspondan se indica que no aplica, por ejemplo: en camas)



(QTC) EDAN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CÓDIGO DEIS:	CÓDIGO ESTACIÓN (QRZ):	Nº EDAN:
SERVICIO:	COMUNA:	REGIÓN:
ELABORADO POR: (QRA)	CARGO/FUNCIÓN:	FECHA/HORA (QTR):
NOMBRE DE EVENTO:		

1. Nombre Establecimiento						
2. Tipo Establecimiento						
3. Estado Evacuación Establecimiento	☐	3.1 No Evacuado	☐	3.2 Evacuación Parcial	☐	3.3 Evacuación Total
4. Operatividad Establecimiento	☐	4.1 Operativo	☐	4.2 Semioperativo	☐	4.3 Inoperativo

5. INFORMACIÓN GENERAL: Descripción de la situación del Establecimiento:

Descripción:

6. AFECTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

¿Hubo Impacto en los funcionarios y/o Usuarios al interior del establecimiento al momento de la emergencia? (QRJ)

Nº de Heridos/Fallecidos	Total (heridos)	Riesgo Vital Graves (rojos)	Mediana Gravedad (amarillos)	Pacientes Leves (verde)	Muertos al interior del establecimiento (negros)	Lugar de Disposición de Cadáveres
6.1. Funcionarios						Descripción:
6.2. Usuarios						

¿Hubo daños Estructurales y/o No Estructurales? (QRJ)

	Describe los Daños Ocurredos
6.3 Estructural	Descripción:
6.4 No Estructural	Descripción:

--	--

¿Se produjo afectación en las Líneas Vitales? (QRJ)

	Seleccione Opción	Describa la afectación producida				
6.5 Telecomunicaciones	☐ Servicio Normal	Descripción:				
	☐ Servicio Intermitente					
	☐ Sin Servicio					
	☐ No Aplica					
6.6 Vías de Acceso	☐ Vías Normales	Descripción:				
	☐ Vías con daños con acceso					
	☐ Sin Acceso					
	☐ No Aplica					
6.7 Gases Clínicos	☐ Servicio Normal	Descripción:				
	☐ Servicio Intermitente					
	☐ Sin Servicio					
	☐ No Aplica					
6.8 Energía Eléctrica de la red de distribución	☐ Servicio Normal	Uso de Generador	☐ SI	☐ NO	Horas de Autonomía	Horas.
	☐ Servicio Intermitente	Descripción:				
	☐ Sin Servicio					
	☐ No Aplica					
6.9 Agua Potable de la red de distribución	☐ Servicio Normal	Uso de Estanque	☐ SI	☐ NO	Horas de Autonomía	Horas.
	☐ Servicio Intermitente	Descripción:				
	☐ Sin Servicio					
	☐ No Aplica					
6.10 Alcantarillado	☐ Servicio Normal	Descripción:				
	☐ Servicio Intermitente					
	☐ Sin Servicio					
	☐ No Aplica					

¿Se interrumpió el funcionamiento de servicios clínicos y/o programas? (QRJ)

	Seleccione Opción	Describa la afectación producida
6.11 Servicio de Urgencia (RRHH, Suministros, Equipos, Infraestructura)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.12 Pabellones (RRHH, Suministros, Equipos, Infraestructura)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.13 UPC (RRHH, Suministros, Equipos, Infraestructura)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.14 Camas básicas (RRHH, Suministros, Equipos, Infraestructura)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.15 Vehículos (Camionetas o ambulancias)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.16 Servicios de apoyo clínico (imagenología, laboratorio clínico, centro de sangre)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.17 Recursos Humanos (RRHH en general)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.18 SAPU / SUR / SAR	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.19 Farmacia	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.20 Vacunatorios	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	

	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.21 Boxes de atención	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.22 Medicamentos e insumos (stock crítico)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.23 Bodegas PNAC - PACAM(Programas de Alimentación complementaria) (Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor)	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	
6.24 Otros (Detallar) _____	☐ Operativo	Descripción:
	☐ Semi Operativo	
	☐ No Operativo	
	☐ No Aplica	

7. DESCRIPCIÓN DE AUMENTO DE CONSULTAS ASOCIADAS AL EVENTO (QRJ)

(Solo Hospitales)	(NUMERO)
7.1 Número pacientes actualmente hospitalizados	
7.2 Número pacientes fallecidos:	
7.3. Número de atenciones desde último reporte:	
7.4. Número de Atenciones Acumulados:	
7.5. Descripción general de Consultas asociadas al evento:	

8. SINTESIS DE LÍNEAS DE ACCIÓN

Descripción:

9. SINTESIS DE NECESIDADES

Descripción:

10. TERMINO DE MENSAJE (QSL)

(QRA) Tx. Por:		(QRA) Rx. Por:		(QTR) F/Hora Rx.	
Cargo Función:		Cargo Función:			

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 51 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

o interrupción de telecomunicaciones tradicionales)	4) Anexo Estación de RA 240722 5) Teléfono Satelital: 881632567646; 6) Red HF MINSAL: (Frec.: 5.420 – 7.660 – 10.450 MHz)
---	---

ii. EDAN Salud Mental (Lo realiza Encargada Salud Mental)

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

La evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) en Salud Mental, es parte fundamental de la evaluación en salud en situaciones de emergencias y desastres, busca definir con la mayor claridad posible la localización, extensión y gravedad de los efectos psicosociales del evento, los factores que pueden influir de manera positiva o negativa en la salud mental de la población, los recursos disponibles, así como identificación de necesidades en esta materia para el establecimiento de prioridades para los planes de acción. Es un proceso dinámico que debe realizarse sistemática y continuamente, mediante instrumentos confiables que faciliten la tarea de recopilación y análisis de la información.

El presente instrumento fue diseñado por la Organización Panamericana de la Salud para guiar la evaluación inicial ofreciendo una apreciación global de tipo cualitativo y que puede ser realizado rápidamente, permitiendo un conocimiento preliminar del impacto de desastre de niveles III y IV, los factores de riesgo y protectores presentes en la comunidad, tratando de identificar las necesidades más inmediatas, considerando que generalmente las medidas y decisiones que se tomen después de las primeras 72 horas en una situación de emergencia sentarán las bases para una respuesta eficaz durante las semanas siguientes.

Instrucciones Generales

- ✓ Este instrumento deberá ser aplicado considerando como unidad de análisis fundamental el territorio asignado a un Centro de Salud Familiar, por lo que se sugiere que sea completado por un referente de salud mental del Centro en conjunto con el equipo de salud.
- ✓ Debe ser construido recolectando información proveniente de los actores claves de la comunidad, de la red de salud, de organismos de intersector, de grupos de ayuda humanitaria y mediante la observación directa, por lo que se recomienda que la información sea consolidada en base al análisis hecho en la primera reunión con motivo del evento del Comité Operativo de Emergencias y/o luego de la Mesa Técnica de Salud Mental en Emergencias o similar.
- ✓ Debe ser enviado por el Director/a del CESFAM, a las 72 horas de ocurrido el evento, al Director de Salud Comunal y los Referentes de Salud Mental y Coordinadores/as de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud y SEREMI de Salud respectivas. Estos actores analizarán y consolidarán la información para incorporarla en sus informes integrales, con sus respectivos enfoques, de gestión de red y salud pública, los que deben ser enviados al DEGREYD.
- ✓ Por la naturaleza de la información contenida es importante que el instrumento y/o sus principales conclusiones, sean conocidos por los comités operativos del sector salud, así como por el comité operativo intersectorial del nivel territorial correspondiente.

✓ El instrumento debe ser usado de manera flexible y adaptándolo a las particularidades de cada contexto.



(QTC) EDAN DE SALUD MENTAL Y COMUNITARIA		
CÓDIGO DEIS:	CÓDIGO ESTACIÓN (QRZ):	Nº EDAN:
SERVICIO:	COMUNA:	REGIÓN:
ELABORADO POR: (QRA)	CARGO/FUNCIÓN:	FECHA/HORA (QTR):
NOMBRE DE EVENTO:		

DATOS DEL REFERENTE TÉCNICO DE SALUD MENTAL RESPONSABLE DEL REPORTE

Nombre del Referente Técnico de Salud Mental	
Cargo del Referente Técnico de Salud Mental	
Email del Referente Técnico de Salud Mental	
Teléfono del Referente Técnico de Salud Mental	
CANTIDAD DE POBLACIÓN ASIGNADA AL ESTABLECIMIENTO	

Nº	EVALUACIÓN	Opciones SI/NO
1. IMPACTO DEL EVENTO EN LA COMUNIDAD		
1	Existencia de heridos o lesionados	
2	Existencia de fallecidos	
3	Existencia de desaparecidos (como producto del suceso)	
4	Existencia de población aislada	
5	Carencia de servicios básicos (electricidad, agua, gas, telecomunicaciones)	
6	Existencia de Población flotante (turistas, en tránsito, etc.)	
7	Desorden y violencia social (riñas, saqueos, desmanes, agresiones)	
8	Conflicto y malestar social (protestas, tomas, etc.)	
9	Ocurrencia de agresiones sexuales	
10	Violencia de género	
11	Maltrato infantil	
12	Secuestros	
13	Grupos de población desplazada	

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 53 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

14	Personas en albergues	
15	Separación de familias	
16	Personas con mucha aflicción, alarmadas, con miedo u otras reacciones emocionales como consecuencia del suceso	
17	Discontinuidad del tratamiento de usuarios con trastorno de salud mental	
18	Alteración en el funcionamiento de las organizaciones comunitarias existentes en el territorio	
19	Funcionarios del establecimiento de salud afectados	
20	Otros respondedores del territorio afectados	
21	Pérdida de fuentes de trabajo	
22	Afectación infraestructura sanitaria	
23	Otras (especifique)	
	FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RESPUESTA DEL EVENTO	
24	Inconformidad comunitaria por las acciones de ayuda	
25	Baja participación de la comunidad en las acciones de respuesta	
26	Información insuficiente, contradictoria o poco confiable	
27	Existencia de rumores o información falsa	
28	Voluntarios desorganizados	
29	Otros (especifique)	
	FACTORES DE VULNERABILIDAD PREVIOS EN LA COMUNIDAD/TERRITORIO	
30	Conflictos políticos, sociales, territoriales o de otra índole	
31	Pobreza	
32	Maltrato infantil	
33	Violencia sexual	
34	Consumo o abuso de alcohol y otras drogas	
35	Prevalencia trastornos mentales	
36	Desorganización comunitaria	
37	Brecha asistencial en salud mental en el territorio	
38	Otros (especifique)	
2. LISTADO DE FACTORES PROTECTORES		
	Previos al evento	
39	Organización comunitaria	
40	Miembros de la comunidad capacitados en salud mental	
41	Coordinación intersectorial	
42	Servicios de salud mental disponibles en la comuna	
	Post Evento	
43	Grupos de ciudadanos que participan activamente en la solución de problemas derivados del evento	
44	Acceso a información confiable y sistemática	
45	Servicios sociales disponibles	
46	Servicios de salud mental disponibles	
47	Programas externos de ayuda humanitaria funcionando	
48	Ayuda gubernamental	
49	Otros	
3. LISTADO DE RECURSOS (Disponibles en el lugar post evento)		
	HUMANOS	
50	Personal del establecimiento con formación en salud mental en emergencias y desastres	
51	Personal de intersector capacitado en salud mental (públicos, ONG'S, etc.)	

52	Agentes comunitarios capacitados en salud mental	
	MATERIALES E INSUMOS	
53	Material de información y difusión sobre el cuidado de la salud mental en emergencias y desastres disponible	
54	Medicamentos (para trastornos de salud mental)	
55	Material Educativo y Lúdico Chile Crece Contigo	
	Organizacional/Institucional	
56	Servicios de salud mental de atención primaria accesible en la comuna	
57	Servicios de salud mental de nivel secundario accesible en la comuna	
58	Plan de emergencias y desastres del establecimiento con componente de protección de la salud mental	
59	Referente salud mental integrante de COGRID establecimiento y/o comunal	
60	Mesa técnica comunal de Salud Mental en emergencias y desastres (o similar)	
61	Otros	
4. LISTADO DE NECESIDADES POST EVENTO (SI: resuelta / NO: no resuelta)		
	PSICOSOCIALES	
62	Orientación e Información clara y oportuna para la comunidad	
63	Contacto y apoyo entre los miembros de la comunidad	
64	Primera Ayuda Psicológica	
65	Cuidado a los equipos de salud	
66	Cuidado a funcionarios públicos y respondedores	
67	Servicios sociales para satisfacción de necesidades de la comunidad	
68	Organización comunitaria	
69	Restablecimiento del funcionamiento de establecimientos educacionales	
70	Liderazgo comunitario	
71	Culturales (acorde con las costumbres y tradiciones locales)	
72	Religiosas o espirituales	
73	Participación de la comunidad en la toma de decisiones	
	INSTITUCIONALES	
74	Capacitación y entrenamiento en salud mental en emergencias y desastres	
75	Consultorías de salud mental	
76	Refuerzo de la red temática de salud mental comunal	
77	Mobilización Equipos de Apoyo a la Respuesta en Salud Mental (ARSAM)	
	BÁSICAS	
78	Comentarios sobre el grado de satisfacción de las necesidades básicas:	

79. SÍNTESIS DE NECESIDADES PRIORITARIAS

80. ACCIONES EN SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL YA REALIZADAS POR LA RED LOCAL

81. ACCIONES EN SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL PLANIFICADAS A REALIZAR POR LA RED LOCAL

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 55 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

TERMINO DE MENSAJE (QSL)

(QRA) Tx. Por:		(QRA) Rx. Por:		(QTR) F/Hora Rx.	
Cargo Función:		Cargo Función:			

Enviar a Coordinador(a) de Servicio de Salud con copia a SEREMI y MINSAL (según medios disponibles en normalidad o interrupción de telecomunicaciones tradicionales)	Según medios disponibles de MINSAL: 1) https://midas.minsal.cl/ 2) Correo Turno MINSAL deyd@minsai.cl 3) Teléfono Móvil Turno MINSAL (+56) 9 89027282 4) Anexo Estación de RA 240722 5) Teléfono Satelital: 881632567646; 6) Red HF MINSAL: (Frec.: 5.420 – 7.660 – 10.450 MHz)
--	---

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 56 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

f. Ficha de Enlaces – Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRID del establecimiento (titulares - suplentes) y otros enlaces relevantes

Esta ficha deberá ser mantenida actualizada por el encargado o Coordinador de emergencias y desastres del establecimiento y difundirlo en los actores relevantes para la respuesta.

Ficha de Enlaces – Titulares/Suplentes					
Área de la Institución (Unidad/departamento)	Función titular o Suplente	Nombre	Cargo	Correo electrónico (institucional/Secundario)	Teléfono Celular 1
DEPARTAMENTO DE SALUD	Titular	ÁNGELA ARAYA V.	JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD	jefadepartamentodesalud@muniperalillo.cl	+56965795010
	Suplente	CLAUDIA DÍAZ	JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD(S)	claudiadiaz@muniperalillo.cl	+56985763282
DIRECCIÓN CESFAM	Titular	CRISTIAN CÁRDENAS E	DIRECTOR	c.cardenas@muniperalillo.cl	+56995415368
	Suplente	BEATRIZ SAN MARTIN R	DIRECTORA (S)	beatrizsanmartin@muniperalillo.cl	+56968259456
SECTOR URBANO	Titular	BEATRIZ SAN MARTIN R	JEFE SECTOR URBANO	beatrizsanmartin@muniperalillo.cl	+56968259456
	Suplente	MARIA CAROLINA CORNEJO Z	REFERENTE ADM. PSCV	carolinacornejo@muniperalillo.cl	+56975253915
SECTOR RURAL	Titular	SANDY GUAJARDO	JEFA SECTOR RURAL	sguajardopadilla@gmail.com	+56964047479
	Suplente	JOSÉ CAYUL O	ENCARGADO MAISFC Y PARTICIPACIÓN	josecayul@muniperalillo.cl	+56961166094
COORDINADOR GRD	Titular	ELIGIO MACHADO R	COORDINADOR GRD	emachado@muniperalillo.cl	+56940227663
	Suplente	CHRISTIAN ROLLE	COORDINADOR GRD (S)	christiancrt7@gmail.com	+56926437745
REFERENTE ADMINISTRATIVO SUR	Titular	MARIA JOSE SOLÍS L	REFERENTE ADM. SUR	mjosolis@muniperalillo.cl	+56996236780
	Suplente	CATHERINE SOTO	REFERENTE ADM SUR (S)	catherinessoto@gmail.com	+56923831704

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 57 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

REFERENTE ADMINISTRATIVO PSCV	Titular	MARIA CAROLINA CORNEJO Z	REFERENTE ADM. PSCV	carolinacornejo@municiperalillo.cl	+56975253915
	Suplente	SANDY GUAJARDO	REFERENTE ADM. PSCV (S)	sguajardopadilla@gmail.com	+56964047479
ENCARGADO UNIDADES DE APOYO (MANTENIMIENTO)	Titular	ESTEBAN LEÓN R	ENCARGADO MANTENIMIENTO	estebanleon@municiperalillo.cl	+56974254480
	Suplente	VÍCTOR OSORIO P	ENCARGADO INFORMATICA	vosorio@municiperalillo.cl	+56981854583
ENCARGADO FARMACIA	Titular	JORGE LÓPEZ	JEFE DE FARMACIA	jorgelopez@municiperalillo.cl	+56999096584
	Suplente	MACARENA GUZMAN	ENCARGADA FARMACIA (S)	guzmanalcaino@gmail.com	+56987987395
ENCARGADO PNAC PACAM	Titular	ANA CAROLINA OGAZ P	ENCARGADO PNAC PACAM	c.ogaz@municiperalillo.cl	+56978078401
	Suplente	BELÉN POLLONI	ENCARGADO PNAC PACAM (S)	belenpolloni@gmail.com	+56996487116
ENCARGADA PARTICIPACION CIUDADANA	Titular	JOSÉ CAYUL	ENCARGADO PART. CIUDADANA	josecayul@municiperalillo.cl	+56961166094
	Suplente	GEMITA CASTRO C	ENCARGADA PART. CIUDADANA (S)	g.castro@municiperalillo.cl	+56958806353
ENCARGADA SALUD MENTAL	Titular	NATALIA SAN MARTIN	ENCARGADA SALUD MENTAL	n.sanmartin@municiperalillo.cl	+56983028065
	Suplente	YORKA ACUÑA O	ENCARGADA SALUD MENTAL (S)	yorkaacuna@municiperalillo.cl	+56974969258
REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO	Titular	NATALIA CERÓN	REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO	cardiovascular.cesfam@municiperalillo.cl	+56953576322
	Suplente	MAURICIO LEÓN	REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO (S)	mleonleon@gmail.com	+56990426601

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 58 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

g. Ficha de Enlaces – Extra Sectorial (titulares - suplentes)

Ficha de Enlaces Extra Sectorial – Titulares/Suplentes					Fecha de Actualización: 06/01/2026		
Organismo/Institución	Función titular o Suplente	Nombre	Cargo	Correo electrónico (institucional/Secundario)	Teléfono Celular 1	Teléfono Celular 2	Teléfono satelital (si aplica)
Carabineros de Chile	Titular	MAURICIO ISLA	SUBOFICIAL MAYOR TENENCIA PERALILLO		+56966041011		
	Suplente	SO GERARDO ARAYA	SUBOFICIAL RETÉN POBLACIÓN		+56951971529		
Bomberos del Sector	Titular	HÉCTOR LORCA	SUPERINTENDENTE	hlorca@muniperalillo.cl	+56983782017		
	Suplente	CLAUDIO CRUZ	COMANDANTE		+56968758766		
Encargado Municipal de emergencia	Titular	MICHEL DONOSO	ENCARGADO COGRID COMUNAL	micheldonoso@muniperalillo.cl	+56954098946		
	Suplente	VÍCTOR MORAGA	ENCARGADO (S) COGRID COMUNAL	victormoraga@muniperalillo.cl	+56962563000		

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 59 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

h. Farmacia – Medicamentos críticos carro de paro SUR y arsenal farmacológico.

PATOLOGÍA	FÁRMACO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
SCA	Aspirina	100 mg	6
	Clopidrogel	75 mg	8
	Atorvastatina	40 mg	4
	Nitroglicerina	50 mg / 10 ml	1
	Tenecteplase	50 mg	1
	Exonaparina	40 mg	2
	Enoxaparina	60 mg	1
Crisis Bronquial	Salbutamol	Solución NBZ	1
	Berodual	Solución NBZ	1
	Hidrocortisona	100 mg	6
	Sulfato de Magnesio	25% 5 ml	2
	Ketamina	500 mg / 10 ml	1
Anafilaxia	Adrenalina	1 mg	3
	Hidrocortisona	500 mg	1
	Clorfenamina	10 mg	1
	Ranitidina	50 mg	1
Hemorragia Digestiva Alta	Omeprazol	40 mg	2
	Ondansetron	4 mg	2
	Terlipresina	1 mg	2
Hiperkalemia	Salbutamol	Solución NBZ	1
	Gluconato de Calcio	1 g / 10 ml	10
	Bicarbonato de Sodio	8,4% 10 ml	4
Hipokalemia	Cloruro de Potasio	10% 10 ml	6
	Sulfato de Magnesio	25% 5 ml	2
Edema Pulmonar Agudo	Nitroglicerina	50mg / 10 ml	6
	Captopril	25 mg	1
	Furosemida	20 mg	10
Fibrilación Auricular	Verapamilo	5 mg	2
	Propanolol	1 mg	5
	Lanatosido	0,4 mg	2
TPVS	Adenosina	6 mg	5
Politraumatizado	Ácido Tranexámico	1 gramo	1
	Ketorolaco	30 mg	4
	Metamizol	1 gramo	4
	Lidocaína	2% 5 ml	4
Crisis Hipertensiva	Labetalol	100 mg	1
PCR	Adrenalina	1 mg	6
	Amiodarona	150 mg	3
	Atropina	1 mg	4
Agitación	Haldol	5 mg	2
Shock	Noradrenalina	4 mg	2
	Adrenalina	1 mg	1
	Dopamina	200 mg	1
Intoxicaciones	Atropina	25 mg	1
	Flumazenil	0,5 mg	1
	Naloxona	0,4 mg	1
Manejo Vía Aérea	Etomidato	20 mg	1
	Propofol	100 mg	2
	Rocuronio	100 mg	2
	Succinilcolina	100 mg	2
Controlados	Fentanil	100 mcg	3
	Diazepam	10 mg	1
	Lorazepam	4 mg	3
	Midazolam	15 mg	1
	Morfina	10 mg	1

FÁRMACO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Ácido Tranexámico	1 gramo	1
Adenosina	6 mg	5
Adrenalina	1 mg	10
Amiodarona	150 mg	3
Aspirina	100 mg	6
Atorvastatina	40 mg	4
Atropina	1 mg	4
Atropina	25 mg	1
Berodual	Solución NBZ	1
Bicarbonato de Sodio	8,4% 10 ml	4
Captopril	25 mg	1
Clopidrogel	75 mg	8
Clorfenamina	10 mg	1
Cloruro de Potasio	10% 10 ml	6
Cloruro de Sodio	10% 10 ml	6
Diazepam	10 mg	1
Enoxaparina	40 mg	2
FÁRMACO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Enoxaparina	60 mg	1
Etomidato	20 mg	1
Fentanil	100 mcg	3
Flumazenil	0,5 mg	1
Furosemida	20 mg	10
Gluconato de Calcio	1 g / 10 ml	10
Haldol	5 mg	2
Hidrocortisona	100 mg	6
Hidrocortisona	500 mg	1
Ketamina	500 mg / 10 ml	1
Ketorolaco	30 mg	4
Labetalol	100 mg	1
Lanatosido	0,4 mg	2
Lidocaína	2% 5 ml	4
Lorazepam	4 mg	3
Metamizol	1 gramo	4
Midazolam	15 mg	1
Morfina	10 mg	1
FÁRMACO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Naloxona	0,4 mg	1
Nitroglicerina	50 mg / 10 ml	2
Noradrenalina	4 mg	2
Omeprazol	40 mg	2
Ondansetron	4 mg	2
Propofol	100 mg	2
Ranitidina	50 mg	1
Rocuronio	100 mg	2
Salbutamol	Solución NBZ	1
Succinilcolina	100 mg	2
Sulfato de Magnesio	25% 5 ml	4
Tenecteplase	50 mg	1
Terlipresina	1 mg	2

i. Programas Alimentarios PNAC - PACAM

PNAC - PACAM					
Nº	Producto	Stock Normal (aproximado)	Stock crítico	Procedimiento de reposición	Responsable
1	Fórmula Prematuros	10 tarros	0	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
2	Fórmula de Inicio	100 tarros	50	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
3	Fórmula Aminoacídica (FAA)	12 tarros	6	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
4	Fórmula extensamente Hidrolizada (FEH)	45 tarros	30	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
5	Purita Cereal	500 kilos	300	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
6	Purita fortificada	200 kilos	100	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
7	Mi sopita	0 kilos	0	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
8	Bebida láctea años dorados	1200 kilos	600	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
9	Purita Mamá	120 kilos	40	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
10	Crema años dorados	1200 kilos	60	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM
11	Formula de continuación	0 tarros	0	Vía intermediación/DSS	Encargada de PNAC PACAM

j. Protocolos y Procedimientos Complementarios Vigentes.

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES
Complementan el presente documento los siguientes protocolos: - Plan Institucional de Evacuación - Plan de contingencia en el caso de interrupción de suministro eléctrico - Plan de Prevención de Incendios - Código Azul

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 62 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

k. Anexo Formato para Acciones de Rehabilitación (Posterior a la contención de emergencia) Levantamiento de información la realizará COGRID

ACCIONES DE REHABILITACIÓN			
Elementos/ Ámbitos	Descripción de acciones	Costos	Plazos
Elementos Estructurales			
Elementos Arquitectónicos			
Protección, acceso y seguridad física de la infraestructura			
Líneas vitales			
Equipos y Suministros			
Restablecimiento de capacidades de las unidades clínicas y de apoyo (considerar Recurso humano entre otras capacidades)			
Acciones de Salud Mental en la Gestión del Riesgo de Desastres			
Otras acciones			

I. Ficha Visita Albergues

El presente Instrumento fue extraído de “Plan Regional para la Respuesta Integrada en Salud Comunitaria en Emergencias y Desastres” del Servicio de Salud Antofagasta.

VISITA ALBERGUES	
Comuna / Población o Sector	
Nombre Albergue	
Encargado Albergue	
Dirección / Ubicación Albergue	
Nombre responsable Recolección información	
Fecha	

Equipo Albergue (nombre / cargo)	Función específica

Equipo Sanitario	Acciones que realizar
Médico	Consultas de morbilidad, control de enfermedades crónicas y otros según necesidad detectada.
Enfermero/a	Vacunación según corresponda (registro RNI), evaluación saneamiento, pesquisa de morbilidades, educación saneamiento (uso de agua, alimentos lavado de manos y aseo personal), consolidación estadística.
Psicólogo/a, trabajador/a Social u otro profesional no médico capacitado	Primera Ayuda Psicológica (PAP)*, pesquisa de salud mental, evaluación saneamiento, catastro de equipo coordinador albergue, catastro antecedentes personas albergadas.
TENS	Entrega de fármacos, apoyo vacunación, pesquisa morbilidades.
Equipo de Salud (Nombres)	

* Primera Ayuda Psicológica (PAP), la que puede ser brindada por cualquier integrante del equipo de salud, capacitado en la temática.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 64 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

m. Glosario

Para el presente Glosario se han utilizado los siguientes documentos para la mayoría de las definiciones:

- **Ley Núm. 21.364 Establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y adecúa Normas que indica.**
- **Glosario Gestión del Riesgo de Desastres**, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Santiago, mayo de 2021, 1era Edición.
- **Guía de Evaluadores Índice de Seguridad Hospitalaria**, Organización Panamericana de la Salud, segunda edición, 2018.
- **Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres**. UNISDR, 2016.

Amenaza: Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. *Comentario: Las amenazas pueden tener origen natural, antropógeno o socionatural. Las amenazas naturales están asociadas predominantemente a procesos y fenómenos naturales. Las amenazas antropógenas o de origen humano son las inducidas de forma total o predominante por las actividades y las decisiones humanas. Este término no abarca la existencia o el riesgo de conflictos armados y otras situaciones de inestabilidad o tensión social que están sujetas al derecho internacional humanitario y la legislación nacional. Varias amenazas son socionaturales, en el sentido de que se asocian a una combinación de factores naturales y antropógenos, como la degradación ambiental y el cambio climático. Las amenazas pueden ser únicas, secuenciales o combinadas en su origen y sus efectos. Cada amenaza se caracteriza por su ubicación, intensidad o magnitud, frecuencia y probabilidad. Las amenazas biológicas también se definen por su infecciosidad o toxicidad, o por otras características del agente patógeno como la relación dosis-respuesta, el período de incubación, la tasa de letalidad y la estimación del patógeno para la transmisión.*¹⁵

Cambio Climático: “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”¹⁶

Capacidad: Combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de una organización, comunidad o sociedad que pueden utilizarse para gestionar y reducir los riesgos de desastres y reforzar la resiliencia.

Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRID: La Ley 21.634, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, crea el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres COGRID, anteriormente denominado Comité de Emergencia y/o Comité Operativo de Emergencia (COE). La citada ley establece en el “Artículo 5.-Estructuras de Coordinación. Créanse los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ejercerán las funciones propias de cada fase, a nivel nacional, provincial, regional y comunal, según corresponda. En las Fases de Mitigación y Preparación aprobarán los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres que establece esta ley, y coordinarán las instancias necesarias para

¹⁵ UNISDR, Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres. 2016.

¹⁶ IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F.,D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 65 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

desarrollar las capacidades y recursos para fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo establecido en el Párrafo 2° del Título I.

Continuidad operacional: “permanencia del funcionamiento de un determinado servicio que, no obstante estar siendo afectado por algún tipo de contingencia, persiste en la prestación mínima del mismo.”¹⁷

Desastre: Disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno o más de los siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales.

Emergencia: Emergencia: evento, o la inminencia de éste, que altere el funcionamiento de una comunidad debido a la manifestación de una amenaza de origen natural, biológico o antrópico, que interacciona con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad de afrontamiento, ocasionando una o más de las siguientes afectaciones: pérdidas, impactos humanos, materiales, económicos o ambientales.

Evacuación: Traslado temporal de personas y bienes a lugares más seguros antes, durante o después de un suceso peligroso con el fin de protegerlos. *Comentario: los planes de evacuación se refieren a las disposiciones establecidas de antemano para permitir el traslado temporal de personas y bienes a lugares más seguros antes, durante o después de producirse un suceso peligroso. Los planes de evacuación pueden incluir planes para el regreso de los evacuados y opciones de alojamiento en el lugar.*

Evacuación parcial: está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro inminente de un establecimiento, pero no de todo el establecimiento comprometido por la emergencia.

Evacuación horizontal: Es el tipo de evacuación que se desarrolla dentro de una misma planta: de una habitación a otra o al pasillo, de una zona a otra, etc., siempre dentro del mismo piso.

Evacuación vertical: Es aquella que comprende el paso de un piso a otro.

Evacuación total: está referida a la evacuación de todas las dependencias de un establecimiento.

Gestión del riesgo de desastres: el proceso continuo de carácter social, profesional, técnico y científico de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres, con el propósito de evitar la generación de nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes y gestionar el riesgo residual. Considerará, además de la organización y gestión de los recursos, las potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos de las emergencias y la administración de las diversas fases del ciclo del riesgo de desastres¹⁸.

Hospital seguro frente a desastres (aplica para establecimientos de APS): establecimiento de salud “...cuyos servicios se mantienen accesibles y en funcionamiento al máximo de su capacidad y con la misma infraestructura antes, durante y después de sufrir el impacto de emergencias y desastres.”¹⁹

¹⁷Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, Resolución Exenta N° 178 de fecha 15 de febrero de 2018, aprueba metodología para la formulación de un nuevo instrumento de planificación para la gestión del riesgo de desastres denominado Plan de Continuidad Operacional, pág. 24.

¹⁸ Ley Núm. 21.364, Establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

¹⁹ Organización Panamericana de la Salud, Índice de Seguridad Hospitalaria, Guía de Evaluadores, segunda edición, pág. 8.

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 66 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

Inclusión para la Gestión del Riesgo de Desastres en hospitales (INGRIDH): Metodología de “evaluación - acción” para mejorar el nivel de preparación para la respuesta hospitalaria en situaciones de emergencia y desastres causados por cualquier tipo de peligro con énfasis en personas con discapacidades²⁰.

Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH): Valor numérico que expresa la probabilidad de que un hospital continúe funcionando en casos de desastre.²¹ Se obtiene mediante el uso de una lista de verificación que contiene una serie de aspectos o variables de evaluación, aplicando estándares de seguridad y asignándole pesos relativos a cada aspecto evaluado.

Instalaciones vitales: Las estructuras físicas, instalaciones técnicas y sistemas principales que son social, económica u operativamente esenciales para el funcionamiento de una sociedad o comunidad, tanto en circunstancias habituales como extremas durante una emergencia.

Mantenimiento: Conjunto de actividades técnicas y administrativas cuya finalidad es conservar, reestablecer un sistema, subsistema, planta, maquina, equipo, estructura, edificio, conjunto, componente o pieza en o a la condición que le permita desarrollar su función ²²

Mitigación: Disminución o reducción al mínimo de los efectos adversos de un suceso peligroso.

Módulo de Emergencias de la Plataforma de Modernización Digital de la Información de la Autoridad Sanitaria (MIDAS): Ante las fases Alerta, Respuesta y Recuperación en una Emergencia, Desastre o Epidemia se activan los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) del Sector Salud, siendo parte de la estructura de gobernanza oficial del Ministerio de Salud ante el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), cuyas funciones consideran los aspectos críticos de la respuesta, incluyendo el análisis del estado de situación y necesidades; la coordinación de las líneas de acción; la elaboración e implementación de planes de trabajo sectoriales e intersectoriales, siendo una de gran relevancia implementación de la Gestión de Información.

Desde el año 2018 se oficializa un instructivo sobre PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE EVENTOS Y LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES POR SERVICIOS DE SALUD Y SEREMI DE SALUD Llamado Circular N°18.

El objetivo del módulo de emergencias de la plataforma MIDAS es dotar a la estructura de gobernanza en gestión del riesgos en emergencias, desastres y epidemias de herramientas digitales para la adecuada coordinación y gestión de información crítica (sistema de reportes) para la toma de decisiones bajo entornos digitales georreferenciados (visores de mapas) propiciando al enfoque de registro, sistematización, intercambio de experiencias y matrices de riesgos regionales incorporando los efectos de cambio climático (repositorio histórico de eventos).

Finalmente, una herramienta que permita consolidar información sobre capacidades de respuesta del sector salud ante emergencias, desastres y epidemias bajo un enfoque de preparativo – respuesta.

Preparación: Conocimientos y capacidades que desarrollan los gobiernos, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder y recuperarse de forma efectiva de los impactos de desastres probables, inminentes o presentes.

Prevención: Actividades y medidas encaminadas a evitar los riesgos de desastres existentes y nuevos.

²⁰Organización Panamericana de la Salud. Inclusión para la gestión del riesgo de desastres en hospitales. Washington, D.C.: OPS; 2018.

²¹ Organización Panamericana de la Salud, Índice de Seguridad Hospitalaria, Guía del Evaluador, primera edición, pág. 15

²²Federación Europea de Asociaciones Nacionales de mantenimiento (EFNMS)

	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A PERALILLO	Versión: 1.0
	PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL	Página 67 de 67
	Fecha: 06-01-2026	

Recuperación: La restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de los planteles, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores de riesgo de desastres.²³

Reducción del riesgo de desastres: La reducción del riesgo de desastres está orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres y la reducción de los existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Rehabilitación: Restablecimiento de los servicios e instalaciones básicos para el funcionamiento de una comunidad o sociedad afectada por un desastre.

Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.²⁴

Respuesta: Medidas adoptadas directamente antes, durante o inmediatamente después de un desastre con el fin de salvar vidas, reducir los impactos en la salud, velar por la seguridad pública y atender las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.

Riesgo de desastres: Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un período de tiempo concreto, determinados de forma probabilística como una función de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad.

Sistema de alerta temprana: Sistema integrado de vigilancia, previsión y predicción de amenazas, evaluación de los riesgos de desastres, y actividades, sistemas y procesos de comunicación y preparación que permite a las personas, las comunidades, los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas adoptar las medidas oportunas para reducir los riesgos de desastres con antelación a sucesos peligrosos.

Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres SINAPRED: Sistema conformado por el conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas con las fases del ciclo del riesgo de desastres, que se organizan desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional, para garantizar una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres, y comprende las normas, políticas, planes y otros instrumentos y procedimientos atinentes a la Gestión del Riesgo de Desastres.

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas.²⁵

²³Organización Panamericana de la Salud, Índice de Seguridad Hospitalaria, Guía de Evaluadores, segunda edición, pág. 137)
²⁴Organización Panamericana de la Salud, Índice de Seguridad Hospitalaria, Guía de Evaluadores, segunda edición, pág. 137)
²⁵Idem 11